



MARATHON™ XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis

en-cs-et-hu-it-lv-pl-sk

Directory

en		Page 3
cs		Strana 12
et		Lehekülg 21
hu		31. oldal
lt		41 puslapis
lv		50 lpp.
pl		Strona 60
sk		Strana 71

MARATHON™ XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis

IMPORTANT INFORMATION – Please Read Before Use

Some products may not be licensed in all jurisdictions.



STERILE

See product label for method

Instructions for use (IFU) website

For access to the e-IFU and any additional languages visit www.e-IFU.com

Implant card, patient information leaflet (PIL) and website

The implant card (and implant card label) is provided in the package with the implant. The information in the patient information leaflet (PIL) is based on the information in this IFU. The ePIL can be found on the website below.

For access to the ePIL visit www.ic.jnjmedicaldevices.com

DEVICE DESCRIPTION

This is an Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) acetabular component with metal x-ray marker wires. A Total Hip Prosthesis is composed of individually packaged metal femoral hip stem, modular metal or ceramic femoral head and 2 piece metal-backed Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), ceramic or all UHMWPE acetabular components designed to replace the natural articular surface of the hip joint.

MATERIALS AND RESTRICTED SUBSTANCES

The information below lists the substances in the implant. Additional trace substances may be present due to the manufacturing process. Please contact the address below for additional information.

These devices are a construct made from Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (97-99% w/w) titanium alloy (1-2% w/w) and stainless steel alloy (less than 1% w/w) depending on the size.

Example of Acronym used on label(s):	Material Description:	Material nominally contains the following substances:
PE, UHMWPE, P1	Ultra-High Molecular Weight Polyethylene	Polyethylene (100%)
T1, Ti1	Titanium Alloy	Titanium (90%) Aluminium (6%) Vanadium (4%)
S2, SS2	Stainless Steel Alloy (316L)	Iron (62%) Chromium (18%) Nickel (14%) Molybdenum (3%) Manganese (2%)

HOW SUPPLIED

These device(s) are individually packaged and supplied STERILE. Remove from the package using accepted aseptic technique only after the correct size has been determined. Do not use these components if the sterile packaging appears damaged or unintentionally opened.

INTENDED USER

These devices are not to be used by unqualified personnel. It is essential that the surgeon and operating room staff are fully conversant with the appropriate surgical technique for the implant and associated instruments.

INTENDED USE (PATIENT TARGET GROUP)

Intended use

Total hip arthroplasty is intended to replace the damaged hip joint articulation in patients where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

WARNING: Use only DePuy modular femoral heads and DePuy acetabular components with DePuy modular femoral stems. The outer diameter of the femoral head **MUST** be matched to the inner diameter of the acetabular component.

Cemented components

This acetabular device labelled "For cemented use only" is intended for use with bone cement.

PATIENT POPULATION

The intended patient population are the skeletally mature where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

INDICATIONS

Total hip replacement is indicated in the following conditions:

1. A severely painful and/or arthritic joint (typically due to non-inflammatory degenerative joint disease)
2. Failed previous hip surgery
3. Acute fracture of the femoral head or neck

CONTRAINDICATIONS

The following conditions are contraindications for total hip replacement:

1. Active local or systemic infection.
2. Loss of musculature, neuromuscular compromise or vascular deficiency in the affected limb rendering the procedure unjustified.
3. Poor bone quality, such as osteoporosis, where, in the surgeon's opinion, there could be considerable migration of the prosthesis or a significant change of the fracture of the femoral shaft and/or the lack of adequate bone to support the implant(s).
4. Charcot's or Paget's disease.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

CAUTION:

- Implants and trials components from different manufacturers or implant systems should never be used together.
- Hip prosthesis components should never be reimplanted. Even though the implant appears undamaged, the implant may have developed microscopic imperfections which could lead to failure.
- Always use a trial prosthesis for trial purposes. Trials should not be assembled with any components intended for permanent implantation. Trials must have the same configuration size, etc., as the corresponding components to be permanently implanted.
- Single use devices manufactured by DePuy have not been designed to undergo or withstand any form of alteration, such as disassembly, cleaning or re-sterilization, after a single patient use. Reuse can potentially compromise device performance and patient safety.
- Do not alter or modify implants in any way unless as described in the surgical technique.
- Quality bone stock is critical to ensure fixation of the device. Consider bone grafting and other reinforcement techniques, especially when performing revision surgery, to seat and support the device.

CAUTION: The following conditions, singularly or concurrently, tend to impose severe loading on the affected extremity, thereby placing the patient at higher risk for failure of the hip replacement:

1. Obesity or excessive patient weight.
2. Manual labour.
3. Moderate to high demand sports participation.
4. High levels of patient activity.
5. Likelihood of falls.
6. Alcohol or drug misuse addiction.
7. Other disabilities, as applicable.

CAUTION: The following conditions singularly or concurrently, tend to adversely affect the fixation of hip replacement implants:

1. Marked osteoporosis or poor bone stock.
2. Metabolic disorders or systemic pharmacological treatments leading to progressive deterioration of solid bone support for the implant (e.g., diabetes mellitus, steroid therapies, immunosuppressive therapies, etc.).
3. History of general or local infections.
4. Severe deformities leading to impaired fixation or improper positioning of the implant.
5. Tumors of the supporting bone structures.
6. Allergic reactions to implant materials (e.g., bone cement, metal).
7. Tissue reactions to implant corrosion or implant wear debris.
8. Disabilities of other joints (i.e., knees and ankles).

NOTE: Diabetes, at present, has not been established as a contraindication. However, because of the increased risk for complications such as infection, slow wound healing, etc., the physician should carefully consider the advisability of hip replacement in the severely diabetic patient.

The surgical and postoperative management of the patient must be carried out with due consideration for all existing conditions. Mental attitudes or disorders resulting in a patient's failure to adhere to the surgeon's orders may delay postoperative recovery and/or increase the risk of adverse effects including implant or implant fixation failure.

Excessive physical activity or trauma to the replaced joint may contribute to premature failure of the hip replacement by causing a change in position, fracture, and/or wear of the implants.

EXPECTED CLINICAL BENEFITS

Total hip arthroplasty is expected to provide increased patient mobility and reduce pain by replacing the damaged hip joint articulation in skeletally mature patients where there is evidence of sufficient sound bone to seat and support the components.

SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE (SSCP)

Some countries or regions have hip replacement registries which monitor the performance of hip implants. This registry data was analysed and shows that for a person's first total hip operation generally 95% (95 out of 100) last more than 10 years. This means that at 10 years about 5% (5 out of 100) of patients may have had additional operations to remove part(s). For revision hip replacement generally 80% last more than 10 years. This device meets this general implant lifetime. The risk of revision for an individual patient will depend on patient specific factors such as their anatomy, medical condition and lifestyle (e.g. weight and activity level), the surgical procedure and process.

A device specific SSCP can be found at the following link:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Note: The Eudamed link will only be available after the Eudamed database goes live.

Reporting of Serious Incidents

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led or might lead to any of the following:

- a) the death of a patient, user or other person,
- b) the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health,
- c) a serious public health threat.

INFORMATION FOR USE

Preoperative

THE SURGEON SHOULD DISCUSS ALL PHYSICAL AND MENTAL LIMITATIONS PARTICULAR TO THE PATIENT AND ALL ASPECTS OF THE SURGERY AND THE PROSTHESES WITH THE PATIENT BEFORE SURGERY. The discussion should include the limitations and possible consequences of joint replacement, the necessity to follow the surgeon's instructions postoperatively and the information provided in the patient leaflet.

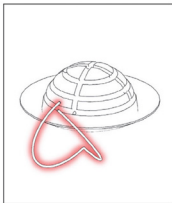
The preoperative planning and surgical techniques for implantation of these hip replacement components evolved from the surgical experience gained during the development of many hip prostheses. Surgeons should not begin the clinical use of any hip prosthesis before they have thoroughly familiarized themselves with its specific implantation technique. Surgical technique brochures are available from DePuy.

Intraoperative

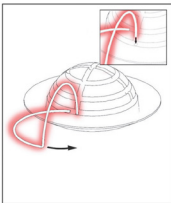
It is recommended that components at least one size larger and one size smaller than were preoperatively determined be available at surgery to accommodate intraoperative selection of the appropriate size(s).

Protective covers should be left on until the components are ready to be implanted. Do not use components if they have been dropped or have impacted a hard surface. Damage to the component may not be visible but could cause early failure of the prosthesis. The surgical instruments identified in the surgical technique have been designed for this arthroplasty procedure and must be used as shown in the surgical technique brochure.

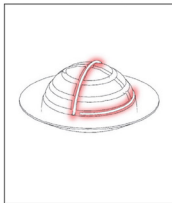
When performing revision surgery, it is imperative that any fibrous membrane encapsulating the failed prosthesis be removed in its entirety. Residual fibrous membranes may interfere with implant fixation. Review any pre-existing devices for damage to mating surfaces that would prevent adequate seating or locking of the new device. Improper selection, placement, or positioning of implants may result in unusual stress conditions and a subsequent reduction in the functional life of the implant. Increasing the anteversion of an acetabular component in total hip replacement may result in instability and/or dislocation. Prior to closure, the surgical site should be thoroughly cleansed of bone chips, extraneous bone cement, ectopic bone, etc. Foreign particles at the metal/plastic or ceramic/plastic interface may cause excessive wear. Range of motion should be thoroughly checked for improper mating, instability, or impingement and corrected as appropriate.



1.



2.



3.

X-Ray Marker Wire Assembly

Postoperative

Strict adherence by the patient to the surgeon's instructions and warnings is extremely important. Accepted practices should be followed in postoperative care.

The patient should be released from the hospital with complete written instructions and warnings regarding exercises and therapies and any limitations on their activities. Component malposition or the use of constrained hip or total hip with modular skirted head or tapered sleeve can decrease joint range of motion and can increase the potential for component wear, impingement premature dislocation or revision. In these cases, the surgeon should inform the patient that high range of motion activities should be avoided.

A continuing periodic patient follow-up is recommended because of the unknown functional lifetime of the implant in the specific patient, particularly with respect to the maintenance of implant fixation and bearing surfaces. Radiological investigations should be performed at each follow-up and compared with previous radiological investigations and correlated with the clinical assessment of the patient. If any radiological changes are observed, such as the occurrence of radiolucencies, bone resorption, or any changes in the position of an implant, these changes should be closely monitored to determine whether they are static or progressive and the patient treated appropriately.

ADVERSE EVENTS AND COMPLICATIONS

The following are generally the most frequently encountered adverse events and complications in hip arthroplasty:

General

The incidence and severity of complications in hip replacement are usually greater in revisions than in primary operations. Common problems encountered in revision surgery may include difficulty in placement of the incision, removal of ectopic bone and old bone cement, positioning and fixation of components, and/or obtaining adequate bony support. In general, increased operative time, blood loss, and risk of infection, pulmonary embolus and wound hematoma can be expected with revision procedures.

General

1. Change in position of the prosthetic components, often related to the factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
2. Early or late loosening of the prosthetic components, often related to factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.

3. Fatigue fracture of the femoral stem or cup component, often related to factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
4. Excessive wear or fracture of the bearing components due to: intraoperative damage to the prosthetic components, loose cement, bone fragments, metallic particles, ceramic particles or other factors listed in WARNINGS AND PRECAUTIONS.
5. Early or late infection.
6. Peripheral neuropathies. Subclinical nerve damage may also occur as a result of surgical trauma.
7. Tissue reactions, osteolysis, and/or implant loosening caused by metallic corrosion, allergic reactions, wear or particulate debris (such as loose cement, metallic, polyethylene or ceramic particles).
8. Residual pain in the hip.

Intraoperative

1. Femoral shaft or acetabular perforation, fissure, or fracture, which may require the use of internal fixation.
2. Trochanteric fracture.
3. Damage to blood vessels (e.g. iliac, obturator and femoral artery).
4. Temporary or permanent nerve damage (e.g. femoral, obturator or isolated peroneal nerve).
5. Subluxation or dislocation of the hip joint due to implant size or configuration selection, positioning of components and/or muscle and fibrous tissue laxity.
6. Lengthening or shortening of the affected extremity.
7. Surgical delay.

Early Postoperative

1. Cardiovascular disorders including venous thrombosis, pulmonary embolism and myocardial infarction.
2. Hematoma and/or delayed wound healing.
3. Subluxation or dislocation.
4. Disassociation of modular components.

Late Postoperative

1. Trochanteric avulsion from excessive muscular tension, weight-bearing, or inadvertent intraoperative weakening of the trochanter.
2. Aggravation of problems in the ipsilateral or contralateral knee and ankle joints due to leg length discrepancy, femoral medialization and/or muscular deficiencies.
3. Acetabular or femoral fracture due to trauma or excessive loading, particularly in the presence of poor bone stock caused by severe osteoporosis, bone defects from previous surgery, intraoperative reaming procedures, or bone resorption.

4. Bone resorption which may contribute to the deterioration of fixation and eventual loosening of the implant.
5. Decrease in joint mobility and range of motion (e.g. maybe caused by periarticular calcification or ossification).
6. Traumatic arthrosis of the ipsilateral knee secondary to intraoperative positioning, of the extremity during surgery.
7. Subluxation or dislocation.
8. Disassociation of modular components.

MRI SAFETY INFORMATION

 MRI Safety Information A patient with the DePuy MARATHON™ XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis construct may be scanned under the following conditions. Failure to follow these conditions may result in injury to the patient.	
Name/Identification of device	MARATHON XLPE Cemented Cup Hip Prosthesis
Nominal value(s) of Static Magnetic Field [T]	1.5 T or 3.0 T
Maximum Spatial Field Gradient [T/m and gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
RF Excitation	Circularly Polarized (CP)
RF Transmit Coil Type	Whole body transmit coil, Head RF transmit-receive coil
Operating Mode	Normal Operating Mode
Maximum Whole Body	2.0 W/kg (Normal Operating Mode)
Maximum Head SAR	Use of a head coil is not required for scanning of the hip
Limits on Scan Duration	2.0 W/kg whole body average SAR. Scan for up to 15 minutes followed by 15 minutes cooling period (may be repeated up to three times in a single imaging session)

MR Image Artifact	The presence of this implant is not expected to produce an image artifact extending further than 108 mm*
Additional instructions or information essential for safe use in the MR environment.	* Check all components of the hip construct for additional MR labelling information.

DISPOSAL

Safely dispose of all devices used in accordance with local procedures and guidelines.

CS NÁVOD K POUŽITÍ

Náhrada kyčelního kloubu s cementovanou jamkou MARATHON™ XLPE

DŮLEŽITÉ INFORMACE – Před použitím si prosím přečtete tento dokument

Některé produkty nemusí mít licenci ve všech jurisdikcích.



STERILE

Metoda viz štítek výrobku

Webová stránka s návodem k použití (IFU)

Pro přístup k eIFU a dalším jazykům navštivte www.e-IFU.com

**Karta implantátu, příbalová informace pro pacienta (PIL)
a webová stránka**

Karta implantátu (a štítek karty implantátu) je součástí balení s implantátem. Informace v příbalové informaci pro pacienta (PIL) vycházejí z informací v tomto návodu k použití. Dokument ePIL je k dispozici na níže uvedené webové stránce.

Pro přístup k ePIL navštivte www.ic.jnjmedicaldevices.com

POPIS PROSTŘEDKU

Jedná se o acetabulární komponent z polyetylenu s velmi vysokou molekulovou hmotností (UHMWPE) s kovovými rentgenovými značkovacími dráty. Totální náhrada kyčelního kloubu se skládá ze samostatně baleného kovového femorálního kyčelního dřívku, modulární kovové nebo keramické femorální hlavice a dvoudílného acetabulárního komponentu z polyetylenu

s velmi vysokou molekulovou hmotností (UHMWPE) a keramiky, popř. jen z UHMWPE, opatřeného kovovým pouzdrům, který nahrazuje přirozený povrch kyčelního kloubu.

MATERIÁLY A ZAKÁZANÉ LÁTKY

Níže uvedené informace uvádějí seznam látek obsažených v implantátu. V důsledku výrobního procesu mohou být přítomny stopové prvky dalších látek. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na adresu uvedenou níže.

Tyto prostředky jsou vyrobeny z polyethylenu s velmi vysokou molekulovou hmotností (97–99 % hm.), titanové slitiny (1–2 % hm.) a slitiny nerezové oceli (méně než 1 % hm.) v závislosti na velikosti.

Příklad akronymu použitého na štítku (štítcích):	Popis materiálu:	Materiál nominálně obsahuje následující látky:
PE, UHMWPE, P1	Polyetylén s ultra vysokou molekulovou hmotností	Polyetylén (100 %)
T1, Ti1	Slitina titanu	Titan (90 %) Hliník (6 %) Vanad (4 %)
S2, SS2	Slitina z nerezové oceli (316L)	Železo (62 %) Chrom (18 %) Nikl (14 %) Molybden (3 %) Mangan (2 %)

ZPŮSOB DODÁNÍ

Tyto prostředky jsou zabaleny samostatně a dodávány STERILNÍ. Vyjměte z obalu pomocí uznávané aseptické techniky teprve po určení správné velikosti. Nepoužívejte tyto komponenty, pokud sterilní obal jeví známky poškození nebo neúmyslného otevření.

ZAMÝŠLENÝ UŽIVATEL

Tyto prostředky nesmí používat nekvalifikovaní pracovníci. Je nezbytné, aby se chirurg a personál na operačním sále plně seznámili s příslušnou chirurgickou technikou určenou pro daný implantát a příslušné nástroje.

ÚČEL POUŽITÍ (CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ)

Účel použití

Účelem totální náhrady kyčelního kloubu je nahradit poškozený kyčelní kloub u pacientů, u nichž je prokázán dostatek zdravé kosti k usazení a podpoře komponent.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze modulární femorální hlavice DePuy a acetabulární komponenty DePuy s modulárními femorálními dříky DePuy. Vnější průměr femorální hlavice MUSÍ odpovídat vnitřnímu průměru acetabulárního komponentu.

Cementované komponenty

Tento acetabulární prostředek s označením „Pouze pro cementované použití“ je určen k použití s kostním cementem.

POPULACE PACIENTŮ

Cílovou populací jsou pacienti s vyvinutou kostrou, u nichž je prokázán dostatek zdravé kosti k usazení a podpoře komponent.

INDIKACE

Totální náhrada kyčelního kloubu je indikována v následujících stavech:

1. Velmi bolestivý a/nebo artritický kloub (obvykle kvůli nezánettlivému degenerativnímu onemocnění kloubů).
2. Předchozí operace kyčle se nezdařila.
3. Akutní zlomenina femorální hlavice nebo krčku.

KONTRAINDIKACE

Následující stavy jsou kontraindikacemi totální náhrady kyčle:

1. Aktivní lokální nebo systémová infekce.
2. Ztráta svalové hmoty, neuromuskulární postižení nebo cévní nedostatečnost postižené končetiny, které činí operaci neopodstatněnou.
3. Špatná kvalita kosti, např. u osteoporózy, při níž podle názoru chirurga hrozí významná migrace implantátu nebo zvýšené riziko periprotetické zlomeniny femorálního dříku, případně nedostatečná kostní opora pro implantát(y).
4. Charcotova nebo Pagetova choroba.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ:

- Implantáty a zkušební komponenty od různých výrobců nebo z různých implantačních systémů by neměly být nikdy kombinovány.
- Kyčelní implantáty by neměly být nikdy reimplantovány. I když se implantát jeví jako nepoškozený, mohou na něm vzniknout mikroskopické vady, které by mohly vést k jeho selhání.

- Pro zkušební účely vždy používejte zkušební náhradu. Zkušební implantáty by neměly být sestavovány z komponent určených pro trvalou implantaci. Zkušební komponenty musí mít stejnou konfiguraci, velikost atd. jako příslušné komponenty určené k trvalé implantaci.
- Prostředky na jedno použití vyrobené společností DePuy nejsou určeny k tomu, aby se daly po použití u jednoho pacienta jakkoli upravovat nebo aby byly odolné vůči jakékoli formě úpravy, jako je demontáž, čištění nebo resterilizace. Při opakovaném použití existuje riziko narušení funkčnosti prostředku a snížení bezpečnosti pro pacienta.
- Implantáty žádným způsobem neupravujte ani nepozměňujte, pokud to není popsáno v chirurgické technice.
- Základem pro zajištění fixace prostředku je kvalitní kostní hmota. Zvažte použití kostního štěpu a další zpevňující techniky pro usazení a zajištění opory prostředku, zejména při revizní operaci.

UPOZORNĚNÍ: Následující stavy, vyskytující se samostatně nebo souběžně, obvykle vedou k velkému zatížení postižené končetiny, v důsledku čehož jsou pacienti vystaveni vyššímu riziku selhání kyčelní náhrady:

1. Obezita nebo nadměrná hmotnost pacienta.
2. Manuální práce.
3. Provozování středně náročných až náročných sportů.
4. Vysoký stupeň aktivity pacienta.
5. Pravděpodobnost pádů.
6. Závislost na alkoholu nebo drogách.
7. Dle situace další postižení.

UPOZORNĚNÍ: Následující stavy, vyskytující se samostatně nebo souběžně, mají obvykle nepříznivý vliv na fixaci implantátů náhrad kyčelního kloubu:

1. Značná osteoporóza nebo nekvalitní kostní hmota.
2. Poruchy metabolismu nebo systémová farmakologická léčba vedoucí k postupnému zhoršování pevnosti kostní opory implantátu (např. cukrovka, léčba steroidy, imunosupresivní terapie atd.).
3. Anamnéza obecných nebo lokálních infekcí.
4. Těžké deformace vedoucí ke zhoršené fixaci nebo nesprávnému umístění implantátu.
5. Nádory nosných kostních struktur.
6. Alergické reakce na materiály implantátu (např. kostní cement, kov).
7. Tkáňové reakce na korozi implantátu nebo nečistoty vzniklé opotřebením implantátu.
8. Postižení jiných kloubů (tj. kolen a kotníků).

POZNÁMKA: Diabetes v současné době není stanoven jako kontraindikace. Nicméně vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací, jako jsou infekce,

pomalé hojení ran atd., by měl lékař u pacienta s těžkým diabetem pečlivě zvážit vhodnost náhrady kyčelního kloubu.

Chirurgická a pooperační léčba pacienta musí patřičně zohledňovat všechny aktuální stavy pacienta. Duševní postoje nebo poruchy vedoucí k nerespektování pokynů lékaře pacientem mohou oddálit zotavení po operaci a/nebo zvýšit riziko nežádoucích účinků, včetně selhání implantátu nebo fixace implantátu.

Nadměrná fyzická aktivita nebo trauma nahrazeného kloubu může přispět k předčasnému selhání náhrady kyčelního kloubu v důsledku změny polohy, zlomeniny a/nebo opotřebení implantátů.

OČEKÁVANÉ KLINICKÉ PŘÍNOSY

Předpokládá se, že totální endoprotéza kyčelního kloubu zajistí lepší mobilitu a sníží bolest nahrazením poškozeného kyčelního kloubu u pacientů s vyvinutou kostrou, u nichž jsou prokázány dostatečně zdravé kosti k usazení a zajištění opory komponent.

SOUHRN BEZPEČNOSTI A KLINICKÝCH VÝSLEDKŮ (SSCP)

Některé země nebo regiony vedou registry náhrad kyčelních kloubů, které monitorují výkonnost kyčelních implantátů. Tato data z registrů byla analyzována a ukazují, že v 95 % případů (tj. u 95 lidí ze 100) vydrží první totální náhrada kyčelního kloubu déle než 10 let. To znamená, že po 10 letech může asi 5 % pacientů (tj. 5 ze 100) vyžadovat dodatečnou operaci pro vyjmutí dílů. U revizní operace náhrady kyčelního kloubu implantát obvykle vydrží déle než 10 let v 80 % případů. Tento prostředek splňuje tuto obecnou životnost implantátu. Riziko revize u daného pacienta bude záviset na konkrétních faktorech, jako je anatomie pacienta, jeho zdravotní stav a životní styl (např. hmotnost a úroveň aktivity), konkrétní chirurgický zákrok a proces. Dokument SSCP pro konkrétní prostředek najdete na následujícím odkazu: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Poznámka: Odkaz na Eudamed bude k dispozici až po spuštění databáze Eudamed.

Hlášení závažných incidentů

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, musí být oznámen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel a/nebo pacient trvalý pobyt.

Vážným incidentem se rozumí jakýkoli incident, který přímo nebo nepřímo vedl, mohl vést nebo by mohl vést k(e):

a) smrti pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

- b) dočasnému nebo trvalému závažnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážnému ohrožení veřejného zdraví.

INFORMACE PRO POUŽITÍ

Před operací

CHIRURG BY MĚL PŘED OPERACÍ S PACIENTEM PROBRAT VŠECHNA TĚLESNÁ I DUŠEVNÍ OMEZENÍ PACIENTA A DÁLE VŠECHNY ASPEKTY OPERAČNÍHO ZÁKROKU A IMPLANTÁTŮ SAMOTNÝCH. Součástí tohoto pohovoru by měla být omezení a možné důsledky aplikace kloubní náhrady, nutnost řídit se pokyny chirurga po operaci a informace uvedené v příbalové informaci.

Předoperační plánování a chirurgické techniky pro implantaci těchto komponent náhrady kyčelního kloubu vycházejí z chirurgických zkušeností získaných během vývoje mnoha různých kyčelních implantátů. Lékaři by neměli začínat s klinickým použitím jakéhokoli kyčelního implantátu, dokud se důkladně neseznámí s jeho specifickou implantační technikou. Brožury chirurgických technik poskytne společnost DePuy.

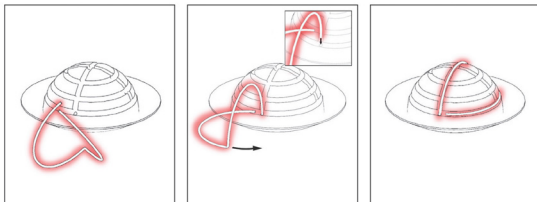
Intraoperační pokyny

Doporučuje se, aby při chirurgickém zákroku byly k dispozici komponenty nejméně o jednu velikost větší a o jednu velikost menší, než bylo předoperačně určeno, aby bylo možno provést výběr vhodné velikosti či vhodných velikostí.

Ochranné kryty by měly zůstat nasazené, dokud nebudou komponenty připraveny k implantaci. Nepoužívejte komponenty, které upadly na zem nebo tvrdý povrch. Poškození komponenty nemusí být viditelné, avšak může způsobit předčasné selhání implantátu. Chirurgické nástroje uvedené v operační technice byly navrženy pro tento artroplastický zákrok a musí se používat tak, jak je uvedeno v brožure o operační technice.

Při revizním chirurgickém zákroku je nezbytné, aby byla zcela odstraněna veškerá vláknitá membrána použitá k zapouzdření náhrady, která selhala. Zbytkové vláknité membrány mohou interferovat s fixací implantátu. Ověřte, zda nejsou na stávajících prostředcích poškozené lícovací povrchy, které by bránily dostatečnému usazení nebo zajištění nového prostředku. Nesprávný výběr, umístění nebo poloha implantátů může mít za následek neobvyklé namáhání a následné snížení funkční životnosti implantátu. Zvýšení anteverted acetabulární komponenty u totální náhrady kyčle může mít za následek nestabilitu a/nebo dislokaci. Před uzavřením musí být operované místo důkladně očištěno od kostních třísek, cizorodého kostního cementu, ektopické kosti atd. Cizorodé částice v místě kontaktu kovu a plastu nebo

keramiky a plastu mohou způsobit nadměrné opotřebení. Rozsah pohybu by měl být důkladně zkontrolován z hlediska případného nesprávného lícování a nestability nebo nárazů a v případě potřeby korigován.



1.

2.

3.

Montáž rentgenového značkovacího drátu

Po operaci

Je mimořádně důležité, aby pacient důsledně dodržoval pokyny a varování lékaře. V rámci pooperační péče musí být dodržovány obecně přijaté postupy.

Pacient by měl být propuštěn z nemocnice s úplnými písemnými pokyny a varováními týkajícími se cvičení a terapií a veškerých omezení aktivity. Špatné umístění komponenty nebo použití omezeného či celého kyčelního kloubu s modulární hlavici nebo kuželovým pouzdrům může snížit rozsah pohybu kloubu a může zvýšit možnost opotřebení komponenty, impingementu, předčasného vykloubení nebo revize. V těchto případech by měl chirurg informovat pacienta, že je třeba se vyhnout aktivitám s velkým rozsahem pohybu.

Kvůli neznámé funkční životnosti implantátu u konkrétního pacienta se doporučuje pokračovat v pravidelném sledování pacienta, zejména s ohledem na zachování fixace implantátu a nosných ploch. Při každé následné návštěvě by měla být provedena radiologická vyšetření, která by měla být porovnána s předchozími radiologickými vyšetřeními a korelována s klinickým hodnocením pacienta. Jsou-li pozorovány jakékoli radiologické změny, jako je výskyt radiolucencí, resorpce kosti nebo jakékoli změny polohy implantátu, je třeba tyto změny pečlivě sledovat a pozorovat, zda jsou statické nebo progresivní, a pacient musí být řádně ošetřován.

NEŽÁDOUCÍ JEVY A KOMPLIKACE

Obecně se nejčastěji vyskytují následující nežádoucí jevy a komplikace náhrad kyčelního kloubu:

Všeobecné

Výskyt a závažnost komplikací při náhradě kyčelního kloubu jsou obvykle vyšší u revizí než u primárních operací. K obvyklým problémům nastávajícím při revizních operacích může patřit obtížné umístění řezu, odstranění ektopické kosti a starého kostního cementu, umístění a fixace komponent a/nebo zajištění adekvátní kostní opory. Obecně lze při revizních zákrocích očekávat delší dobu operace, větší ztrátu krve a riziko infekce, plicní embolie nebo hematomu rány.

Všeobecné

1. Změna polohy komponent implantátu, často související s faktory uvedenými v části VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ.
2. Předčasné nebo pozdější uvolnění komponent implantátu, často související s faktory uvedenými v části VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ.
3. Únavová zlomenina femorálního dřívku nebo komponentu jamky, často související s faktory uvedenými v části VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ.
4. Nadměrné opotřebení nebo zlomení nosných komponent v důsledku: intraoperačního poškození komponent implantátu, uvolněného tmelu, úlomků kostí, kovových částic, keramických částic nebo jiných faktorů uvedených v části VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ.
5. Raná nebo pozdní infekce.
6. Periferní neuropatie. V důsledku chirurgického traumatu může dále dojít k subklinickému poškození nervů.
7. Tkáňové reakce, osteolýza a/nebo uvolnění implantátu způsobené korozí kovu, alergickými reakcemi, opotřebením nebo úlomky částic (např. uvolněný cement, kovové, polyetylenové nebo keramické částice)
8. Zbytková bolest v kyčli.

Intraoperační

1. Perforace, prasklina nebo zlomenina femorálního dřívku nebo acetabulárního komponentu, případně vyžadující použití vnitřní fixace.
2. Trochanterická fraktura.
3. Poškození cév (např. kyčelní, obturátorová a femorální arterie).
4. Dočasné nebo trvalé poškození nervů (např. femorální, obturátorový nebo izolovaný peroneální nerv).
5. Subluxace nebo dislokace kyčelního kloubu v důsledku velikosti implantátu nebo zvolené konfigurace, umístění komponent a/nebo ochabnutí svalové a vláknité tkáně.
6. Prodloužení nebo zkrácení postižené končetiny.
7. Zpoždění operace.

Rané pooperační

1. Kardiovaskulární poruchy včetně žilní trombózy, plicní embolie a infarktu myokardu.
2. Hematom a/nebo pozdní hojení ran.
3. Subluxace nebo dislokace.
4. Disociace modulárních komponent.

Pozdní pooperační

1. Avulze trochanteru vlivem nadměrného svalového napětí, zatěžování nebo neúmyslné intraoperační oslabení trochanteru.
2. Zhoršení problémů ipsilaterálních nebo kontralaterálních kolenních a kotníkových kloubů v důsledku nestejně délky dolních končetin, medializace femuru a/nebo svalové nedostatečnosti.
3. Acetabulární nebo femorální zlomenina v důsledku traumatu nebo nadměrného zatížení, zejména následkem nekvalitní kostní hmoty v důsledku těžké osteoporózy, kostních defektů způsobených předchozím chirurgickým zákrokem, intraoperačním vystružením nebo kostní resorpcí.
4. Kostní resorpce, která může přispět ke zhoršení fixace a případnému uvolnění implantátu.
5. Snížení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu (např. v důsledku periartikulární kalcifikace nebo osifikace).
6. Traumatická artróza ipsilaterálního kolene následkem intraoperačního umístění končetiny během operace.
7. Subluxace nebo dislokace.
8. Disociace modulárních komponent.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE K VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ



Bezpečnostní informace k vyšetření magnetickou rezonancí

Pacient s konstrukcí kyčelní protézy DePuy MARATHON™ XLPE s cementovanou jamkou může být vyšetřen za následujících podmínek. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek zranění pacienta.

Název/identifikace prostředku	Kyčelní protéza MARATHON XLPE s cementovanou jamkou
Jmenovitá hodnota statického magnetického pole [T]	1,5 T nebo 3,0 T

Maximální prostorový gradient pole [T/m a gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
VF buzení	Kruhová polarizace (CP)
Typ VF vysílací cívky	Celotělová vysílací cívka, hlavová VF vysílací–přijímací cívka
Provozní režim	Normální provozní režim
Maximální hodnota celého těla	2,0 W/kg (normální provozní režim)
Maximální hodnota SAR hlavy	Pro snímání kyčelního kloubu není nutné používat hlavovou cívku.
Omezení doby vyšetření	Průměrná hodnota SAR celého těla 2,0 W/kg. Snímání po dobu až 15 minut s následnou 15minutovou dobou ochlazování (může být opakováno až třikrát v průběhu jednoho zobrazování)
Artefakt MR snímku	Nepředpokládá se, že přítomnost tohoto implantátu způsobí obrazový artefakt delší než 108 mm*
Další pokyny nebo informace nezbytné pro bezpečné použití v prostředí MR.	* Zkontrolujte všechny součásti konstrukce kyčelního kloubu kvůli dalším informacím ohledně MR.

LIKVIDACE

Všechny použité prostředky bezpečně zlikvidujte v souladu s místními postupy a směrnicemi.



KASUTUSJUHEND

Tsemenditud kapsliga puusaprotees MARATHON™ XLPE

TÄHTIS TEAVE – lugege enne kasutamist

Mõned tooted ei pruugi olla litsentsitud kõigis jurisdiktsioonides.



STERILE

Meetodit vaadake tootesildilt

Kasutusjuhendi (IFU) veebileht

Elektroonilise kasutusjuhendi (eIFU) ja teistes keeltes dokumendid
leiate veebisaidilt www.e-IFU.com

Implantaadikaart, patsiendi infoleht ja veebisait

Implantaadikaart (ja implantaadikaardi silt) on implantaadiga kaasas olevas pakendis. Patsiendi infolehel olev teave põhineb selles kasutusjuhendis oleval teabel. ePIL-i leiate alltoodud veebisaidilt.

Elektroonilise patsienditeabe (ePIL) leiate veebisaidilt
www.ic.jnjmedicaldevices.com

SEADME KIRJELDUS

Tegemist on ülisuure molekulmassiga polüetüleenist (UHMWPE) ja metalltraadist röntgenimarkeriga puusanapakomponendiga. Puusaliigese protees koosneb eraldi pakitud puusaliigese reieluu metallvarrest, modulaarsest metallist või keraamilisest reieluupeast ja 2-osalisest metalltoega ülisuure molekulmassiga polüetüleenist (UHMWPE), keraamikast või kõigist atsetabulaarsetest UHMWPE-komponentidest, mis on mõeldud asendada loomulikku puusaliigese liigendpinda.

MATERJALID JA PIIRATUD KASUTUSEGA AINED

Allpool on toodud implantaadis sisalduvad ained. Tootmisprotsessi tõttu võib leiduda täiendavaid jääkaineid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust allpool toodud tootja aadressil.

Need seadmed on valmistatud ülisuure molekulmassiga polüetüleenist (97–99 mahuprotsenti), titaanisulamist (1–2 mahuprotsenti) ja roostevaba terase sulamist (vähem kui 1 mahuprotsent) olenevalt suuruselt.

Märgisel (siltidel) kasutatud lühendi näide	Materjali kirjeldus	Nominaalne ainete sisaldus materjalis
PE, UHMWPE, P1	Ülisuure molekulmassiga polüetüleen	Polüetüleen (100%)
T1, Ti1	Titaanisulam	Titaan (90%) Alumiinium (6%) Vanaadium (4%)
S2, SS2	Roostevaba terase sulam (316L)	Raud (62%) Kroom (18%) Nikkel (14%) Molübdeen (3%) Mangaan (2%)

TARNIMISVIIS

Need seadmed on eraldi pakendatud ja tarnitakse STERIILSENA. Võtke seade aseptilise tehnika abil pakendist välja alles siis, kui õige suurus on kindlaks määratud. Ärge kasutage neid komponente, kui steriilne pakend tundub olevat kahjustatud.

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

Neid seadmeid ei tohi kasutada kvalifitseerimata töötajad. Väga oluline on, et kirurg ja operatsioonitoa töötajad järgiksid nii implantaate kui ka vastavaid instrumente käsitsedes täielikult asjakohaseid kirurgilisi meetodeid.

KAVANDATUD KASUTUS (PATSIENTIDE SIHTRÜHM)

Kavandatud kasutus

Puusaligese artroplastika on mõeldud patsientidel kahjustatud puusaligese liigendi asendamiseks siis, kui on tõendeid piisavalt tervest luust, et komponente paigaldada ja toetada.

HOIATUS Kasutage DePuy modulaarsete reieluuvartega ainult DePuy modulaarseid reieluuppeasid ja DePuy puusanapakomponente. Reieluupea välisläbimõõt PEAB vastama puusanapakomponendi siseläbimõõdule.

Tsemenditud komponendid

See puusanapaseade sildiga „Ainult tsemenditud kasutamiseks“ on ette nähtud kasutamiseks luutsemendiga.

PATSIENTIDE POPULATSIOON

Patsientide sihtpopulatsioon on küpse luustikuga patsiendid, kellel on tõendeid piisavalt tervest luust, et komponente paigaldada ja toetada.

NÄIDUSTUSED

Puusaligese täielik asendamine on näidatud järgmistel tingimustel.

1. Tugevalt valulik ja/või artriitiline liiges (tavaliselt mittepõletikulise degeneratiivse liigesehaiguse tõttu).
2. Eelmise puusaoperatsiooni ebaõnnestumine.
3. Reieluupea või -kaela äge murd.

VASTUNÄIDUSTUSED

Järgmistel tingimustel on puusaligese täielik asendamine vastunäidustatud.

1. Äge lokaalne või süsteemne infektsioon.
2. Haaratud jäseme lihasmassi kadu, neuromuskulaarsed häired või vaskulaarne puudulikkus, mille puhul protseduur pole õigustatud.
3. Halb luukvaliteet, näiteks osteoporoosi puhul, kus kirurgi arvates võib tekkida proteesi märkimisväärne migreerumine või on suur oht reieluu

diafüüsi murru tekkeks ja/või pole piisavalt implantaati (implantaate) toestavat luud.

4. Charcot' või Pageti haigus.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD ETTEVAATUST!

- Eri tootjate implantaate ja proovikomponente või implantaadisüsteeme ei tohi kunagi koos kasutada.
- Puusaproteesi komponente ei tohi kunagi uuesti implanteerida. Isegi kui implantaat näib olevat kahjustamata, võivad implantaadil olla tekkinud mikroskoopilised puudused, mis võivad põhjustada probleeme.
- Kasutage proovimiseks alati prooviproteesi. Prooviproteeze ei tohi kokku panna ühegi püsivaks implanteerimiseks mõeldud komponendiga. Prooviproteesidel peab olema sama konfiguratsioonisuurus jne nagu vastavatel komponentidel, et neid püsivalt implanteerida.
- DePuy ühekordselt kasutatavad seadmed ei ole ette nähtud taluma üksikõik millist töötlemist (nagu lahtivõtmine, puhastamine või resteriliseerimine) pärast ühel patsiendil kasutamist. Korduskasutus võib vähendada seadme toimivust ja patsiendi ohutust.
- Ärge implantaate mingil viisil muutke ega modifitseerige, välja arvatud juhul, kui seda on kirjeldatud kirurgilises tehnikas.
- Kvaliteetne luuvaru on seadme fikseerimise tagamiseks kriitilise tähtsusega. Seadme paigaldamiseks ja toestamiseks kaaluge luu siirdamist ja muid tugevdustehnikaid, eriti revisioonioperatsiooni läbiviimisel.

ETTEVAATUST! Järgmised tingimused, üksikult või samaaegselt, põhjustavad kahjustatud jäsemele tugevat koormust, mis seab patsiendi suuremasse puusaliigese asendamise ebaõnnestumise ohtu.

1. Rasumine või patsiendi liigne kehakaal.
2. Füüsiline töö.
3. Mõõdukas kuni väga nõudlik spordis osalemine.
4. Patsiendi suur aktiivsus.
5. Kukkumiste tõenäosus.
6. Alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine.
7. Muud asjassepuutuvad puuded.

ETTEVAATUST! Järgmised tingimused üksikult või samaaegselt mõjutavad negatiivselt puusaliigese implantaatide fikseerimist.

1. Märgatav osteoporoos või kehv luuvaru.
2. Ainevahetushäired või süsteemsed farmakoloogilised ravimeetodid, mis viivad implantaadi tugeva luukoe järkjärgulise halvenemiseni (nt suhkurtõbi, steroidravi, immunosupressiivne ravi jne).
3. Anamneesis üldised või lokaalsed infektsioonid.

4. Tõsised deformatsioonid, mis põhjustavad implantaadi valet fikseerimist või positsioneerimist.
5. Toestavate luustruktuuride kasvajad.
6. Allergilised reaktsioonid implantaadmaterjalidele (nt luutsement, metall).
7. Kudede reaktsioonid implantaadi korrosioonile või implantaadi kulumisjäätmetele.
8. Muude liigeste (st põlvede ja pahklude) puuded.

MÄRKUS. Praegu ei ole diabeet vastunäidustustena tõestatud. Siiski peaks tüsistuste, nagu infektsioon, haavade aeglane paranemine jms, suurenenud riski tõttu arst hoolikalt kaaluma puusaliigese asendamise otstarbekust raskelt diabeetilisel patsiendil.

Patsiendi kirurgiline ja operatsioonijärgne ravi peab toimuma kõiki olemasolevaid seisundeid arvesse võttes. Vaimne hoiak või häired, mille tagajärjel patsient ei järgi kirurgi korraldusi, võivad operatsioonijärgset taastumist edasi lükata ja/või suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas implantaadi või selle fikseerimise ebaõnnestumise riski.

Liigne füüsiline koormus või asendatud liigese trauma võivad põhjustada puusaliigese enneaegset ebaõnnestumist, põhjustades asendimuutust, luumurdu, ja/või implantaatide kulumist.

OODATAV KLIINILINE KASU

Puusa artroplastika pakub patsiendile suuremat liikuvust ja vähendab valu, asendades küpse luustikuga patsientidel kahjustatud puusaliigese liigendi, kui on tõendeid piisavalt tervest luust komponentide paigaldamiseks ja toetamiseks.

OHUTUSE JA KLIINILISE TOIMIVUSE KOKKUVÕTE (SSCP)

Mõnes riigis või piirkonnas on loodud puusaproteesiregistrid, millega jälgitakse puusaimplantaatide toimivust. Neid registriandmeid on analüüsitud ja tulemus näitab, et inimese esimene kogu puusaliigese operatsioon kestab üldjuhul 95% juhtudest (95 juhul 100-st) kauem kui 10 aastat. See tähendab, et 10 aasta pärast võis ligikaudu 5% (100-st 5) patsientidest vajada lisaoperatsiooni osa(de) eemaldamiseks. Puusaliigese asendamise revisioonil kestab tulemus 80% juhtudest tavaliselt üle 10 aasta. Seade vastab taolisele implantaadi üldisele kasutusajale. Üksiku patsiendi puhul sõltub revisiooni risk patsiendi spetsiifilistest teguritest, nagu tema anatoomia, tervislik seisund ja elustiil (nt kehakaal ja aktiivsustase), kirurgiline protseduur ja protsess.

Seadmekohase SSCP leiate järgmiselt lingilt:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Märkus. Eudamedi link on saadaval alles pärast Eudamedi andmebaasi avaldamist.

Tõsistest juhtumitest teatamine

Kõigist seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja pädevat asutust liikmesriigis, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Tõsine juhtum tähendab mis tahes juhtumit, mis otseselt või kaudselt põhjustas, võis põhjustada või võib põhjustada ükskõik mida järgmistest:

- a) patsiendi, kasutaja või muu inimese surm,
- b) patsiendi, kasutaja või muu inimese tervises seisundi ajutine või püsiv tõsine halvenemine,
- c) tõsine oht rahvatervisele.

TEAVE KASUTAJALE

Enne operatsiooni

KIRURG PEAB ENNE OPERATSIOONI ARUTAMA PATSIENDIGA KÕIKI PATSIENTI PUUDUTAVAD FÜÜSILISI JA VAIMSEID PIIRANGUID NING KÕIKI OPERATSIOONI JA PROTEESIGA SEOTUD ASPEKTE. Arutelu peaks hõlmama liigese asendamise piiranguid ja võimalikke tagajärgi, vajadust järgida operatsioonijärgseid kirurgi juhiseid ja patsiendi infolehes sisalduvat teavet.

Nende puusaliigese asenduskomponentide operatsioonieelne planeerimine ja kirurgilised meetodid kujunesid välja paljude puusaproteeside väljatöötamisel saadud kirurgilistest kogemustest. Kirurgid ei tohiks puusaproteeside kliinilist kasutamist alustada enne, kui nad on selle spetsiifilise implantatsioonitehnikaga põhjalikult tutvunud. Kirurgilise tehnika voldikud on saadaval ettevõttelt DePuy.

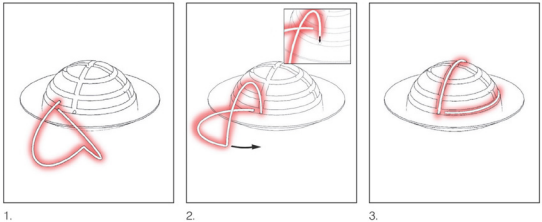
Operatsiooni ajal

Operatsioonil on soovitatav käepärast hoida vähemalt üks suurus suurem ja üks suurus väiksem komponent kui operatsioonieelselt kindlaks määrati, et võimaldada operatsiooni ajal valida sobiv(ad) suurus(ed).

Kaitsekatted tuleb jätta peale, kuni komponendid on implanteerimiseks valmis. Ärge kasutage komponente, kui need on maha kukkunud või põrganud vastu kõva pinda. Komponenti kahjustus ei pruugi olla nähtav, kuid võib põhjustada proteesi varajase nurjumise. Selle artroplastikaprotseduuri jaoks on mõeldud kirurgilises tehnikas ette nähtud kirurgilised instrumendid ja neid tuleb kasutada kirurgilise tehnika juhendi kirjelduste kohaselt.

Revisioonikirurgia korral on hädavajalik, et kõik nurjunud proteesi kapseldavad kiulised membraanid eemaldataks tervikuna. Kiuliste membraanide jäägid võivad häirida implantaadi fikseerimist. Vaadake

üle kõik olemasolevad seadmed sobituspindade kahjustuste suhtes, mis takistaksid uue seadme piisavat sobitumist või lukustumist. Implantaatide vale valik, paigaldus või paigutus võib põhjustada ebatavalisi stressitingimusi ja järgnevat implantaadi funktsionaalse eluea vähenemist. Puusanapakomponendi anteveriooni suurendamine puusaliigese täielikul asendamisel võib põhjustada ebastabiilsust ja/või nihestust. Enne sulgemist tuleb lõikuskoht põhjalikult puhastada luukildudest, kõrvalisest luutsemendist, ektoopilisest luust jne. Võõrosakesed metalli/plasti või keraamika/plasti kokkupuutekohas võivad põhjustada liigset kulumist. Liikumisolatust tuleb põhjalikult kontrollida sobimatu ühildumise, ebastabiilsuse või vastasmõju suhtes ning vajaduse korral korrigeerida.



Röntgenimarkeri traadikoost

Pärast operatsiooni

Patsient peab rangelt jälgima kirurgi juhiseid ja hoiatusi. Operatsioonijärgses hoolduses tuleks järgida tunnustatud tavasid.

Haiglast välja kirjutamisel tuleb patsiendile kaasa anda täielikud kirjalikud juhised ja hoiatused harjutuste, teraapiate ning tegevuspiirangute kohta. Komponenti valesti paiknemine või piiratud liikuvusega puusa kasutamine või modulaarse varjestatud peaosaga implantaadi või koonilise muhvi kasutamine võib vähendada liigese liikumisulatust ja suurendada komponendi kulumise, kahjustumise, enneaegse nihkumise või korrigeerimisvajaduse tekkimist. Sellistel juhtudel peab kirurg patsienti teavitama vajadusest vältida suure ulatusega liigutuste tegemist.

Implantaadi teadmata funktsionaalse kasutusea tõttu konkreettsel patsiendil on soovitatav patsienti jätkuvalt jälgida, eriti implantaadi fikseerumise ja kandepindade säilumise osas. Radioloogilised uuringud tuleb läbi viia

igal järelkontrollil, võrrelda neid varasemate radioloogiliste uuringutega ja korreleerida patsiendi kliinilise hinnanguga. Kui täheldatakse mingeid radioloogilisi muutusi, nagu röntgenkontrastsuse esinemine, luu resorptsioon või implantaadi asukoha muutused, tuleb neid hoolikalt jälgida, et teha kindlaks, kas need on staatilised või progresseeruvad, ja patsienti tuleb asjakohaselt ravida.

KÕRVALTOIMED JA TÛSISTUSED

Puusaligese artroplastika kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed ja tÛsistused on järgmised.

Üldine

Puusaligese asendamise tÛsistuste esinemissagedus ja raskusaste on revisioonidel tavaliselt suurem kui esmaste operatsioonide korral. Revisioonikirurgias esinevad levinumad probleemid võivad olla raskused sisselõike paigutamisel, ektoopilise luu ja vana luutsemendi eemaldamisel, komponentide positsioneerimisel ja fikseerimisel ja/või piisava luutoe saamine. Üldiselt võib revisiooniprotseduuride korral oodata operatsiooni aja pikenemist, verekaotust ja infektsiooniriski, kopsuembooliat ning haava hematoomi.

Üldine

1. Muutused proteesikomponentide asendis, mis on sageli seotud jaotises HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD loetletud teguritega.
2. Proteesikomponentide varane või hiline lõtvumine, mis on sageli seotud jaotises HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD loetletud teguritega.
3. Reieluuvare või kapslikomponendi väsimusmurd, mis on sageli seotud jaotises HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD loetletud teguritega.
4. Kandvate komponentide liigne kulumine või purunemine, mis on tingitud: proteesikomponentide operatsiooniaegsest kahjustumisest, lahtisest tsemendist, luukildudest, metallosakestest, keraamilistest osakestest või muudest jaotises HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD loetletud teguritest.
5. Varajane või hiline infektsioon.
6. Perifeersed neuropaatiad. Kirurgilise trauma tagajärjel võivad tekkida ka subkliinilised närvikahjustused.
7. Metallikorrosioonist, allergilistest reaktsioonidest, kulumisest või tahketest osakestest (nagu lahtine tsement, metalli-, polüetüleen- või keraamikaosakesed) põhjustatud kooreaktsioonid, osteolüüs ja/või implantaadi lõtvumine.
8. Jääkvalu puusas.

Operatsiooni ajal

1. Reieluuvare või puusanapa perforatsioon, lõhenemine või murd, mis võib nõuda sisemise fikseerimise kasutamist.
2. Trohhanteerne murd.
3. Veresoonte kahjustus (nt niude-, sulgur- ja reiearter).
4. Ajutine või püsiv närvikahjustus (nt reie-, sulgur- või isoleeritud peroneaalne närv).
5. Puusaliigese subluksatsioon või nihkumine implantaadi suuruse või konfiguratsiooni valiku, komponentide paigutuse tõttu ja/või lihaste ja kiuliste kudede lõtvus.
6. Mõjutatud jäsme pikenemine või lühenemine.
7. Lõikuse hilinemine.

Varakult pärast operatsiooni

1. Kardiovaskulaarsed häired, st veenitromboos, kopsuemboolia ja müokardiinfarkt.
2. Hematoom ja/või hilinev haavade paranemine.
3. Subluksatsioon või nihkumine.
4. Moodulkomponentide lahtitulek.

Hiljem pärast operatsiooni

1. Trohhanteeriline eraldumine liigse lihaspinge, raskuse või trohhanteri tahtmatu operatsiooniaegse nõrgenemise tõttu.
2. Ipsilateraalsete või kontralateraalsete põlve- ja hüppeliigeste probleemide süvenemine jalgade pikkusevahe, reieluu medialiseerumise tõttu ja/või lihasvaegused.
3. Puusanapa- või reieluumurd trauma või liigse koormuse tõttu, eriti raskest osteoporoosist tingitud kehva luuvaru või varasematest operatsioonidest, operatsiooniaegsetest hõõritsemisprotseduuridest või luu resorptsioonist põhjustatud luudefektide korral.
4. Luu resorptsioon, mis võib soodustada fiksatsiooni halvenemist ja implantaadi lõtvumist.
5. Liigese liikuvuse ja liikumisulatuse vähenemine (nt tingitud periartikulaarsest kaltsifikatsioonist või ossifikatsioonist).
6. Jäsme operatsiooniaegse positsioneerimise järgne ipsilateraalne põlve traumaatiline artroos.
7. Subluksatsioon või nihkumine.
8. Moodulkomponentide lahtitulek.

MRT OHUTUSTEAVE



MRT ohutusteave

Tsementeeritud kapsli puusaliigese proteesi DePuy MARATHON™ XLPE konstruktsiooniga patsienti võib skaneerida järgmistel tingimustel. Nende tingimuste eiramine võib lõppeda patsiendi vigastustega.

Seadme nimi/tunnus	Tsemenditud kapsliga puusaliigese protees MARATHON XLPE
Staatilise magnetvälja nimiväärtus(ed) [T]	1,5 T või 3,0 T
Maksimaalne ruumiline gradient [T/m ja Gs/cm]	30 T/m (3000 Gs/cm)*
RF ergastus	Tsirkulaarselt polariseeritud (CP)
RF-ülekanDEMähise tüüp	Kogu keha ülekanDEMähis, pea RF-ülekanDE-/vastuvõtumähis
Töörežiim	Tavaline töörežiim
Kogu keha maksimaalne	2,0 W/kg (tavaline töörežiim)
Pea maksimaalne SAR	Puusa skaneerimiseks pole peamähise kasutamine nõutav
Skaneerimiskestuse piirangud	2,0 W/kg kogu keha keskmine SAR. Skannige kuni 15 minutit, millele järgneb 15-minutiline jahutusperiood (võib korrata kuni kolm korda ühe pildiseansi jooksul)
MR-pildiartefakt	Eeldatavalt ei tekita selle implantaadi olemasolu suuremat pildiartefakti kui 108 mm*
Täiendavad juhised või teave, mis on vajalik ohutuks kasutamiseks magnetresonantsi keskkonnas.	* Kontrollige kõiki puusakonstruktsiooni komponente täiendava teabe saamiseks MR-märgistuse kohta.

KÖRVALDAMINE

Körvaldage kõik kasutatud seadmed ohutult kohalike protseduuride ja eeskirjade kohaselt.

hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MARATHON™ XLPE cementezett csípővápa-protézis

FONTOS TUDNIVALÓK – Kérjük, használat előtt olvassa el!

Előfordulhat, hogy egyes termékek nem minden joghatóságban licencelhetők.



STERILE

A módszert a termék címkéjén találja

A használati útmutató weboldala

Az elektronikus használati utasításért és további nyelvekért látogasson el ide: www.e-IFU.com

Implantátumkártya, betegtájékoztató (PIL) és weboldal

Az implantátumkártya (és az implantátumkártya címkéje) az implantátummal együtt a csomagban található. A betegtájékoztatóban (PIL) található információk a használati útmutatóban található információkon alapulnak. Az elektronikus betegtájékoztató (ePIL) az alábbi weboldalon érhető el.

Az elektronikus betegtájékoztató eléréséhez látogasson el ide: www.ic.jnjmedicaldevices.com

ESZKÖZLEÍRÁS

Ez egy ultranagy molekulatömegű polietilénből (UHMWPE) készült acetabuláris komponens fém röntgenjelölő drótokkal. Egy teljes csípőprotézis egyedileg csomagolt fém femorális csípőszárból, moduláris (elemekből álló) fém vagy kerámia femorális fejből és 2 db fémhátú, ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE), kerámia vagy csak UHMWPE acetabuláris komponensből áll, amely a csípőízület természetes ízületi felszínének pótlására szolgál.

ANYAGOK ÉS KORLÁTOZOTTAN FELHASZNÁLHATÓ VEGYI ANYAGOK

Az alábbi információk az implantátum anyagainak felsorolását tartalmazzák. A gyártási folyamat miatt nyomokban további anyagok is jelen lehetnek. Az alábbi címen további tájékoztatást kérhet.

Ezek az eszközök méretüktől függően ultranagy molekulatömegű polietilénből (97–99 tömeg%), titánötvözetből (1–2 tömeg%) és rozsdamentesacél-ötvözetből (kevesebb mint 1 tömeg%) készült szerkezetek.

Példa a címké(ke)n használt mozaikszavakra:	Anyagleírás:	A termék névlegesen a következő anyagokat tartalmazza:
PE, UHMWPE, P1	Ultranagy molekulatömegű polietilén	Polietilén (100%)
T1, Ti1	Titánötvözet	Titán (90%) Alumínium (6%) Vanádium (4%)
S2, SS2	Rozsdamentesacél-ötvözet (316L)	Vas (62%) Króm (18%) Nikkel (14%) Molibdén (3%) Mangán (2%)

KISZERELÉS

Ez(ek) az eszköz(ök) egyedileg csomagoltak és STERIL állapotban kerülnek szállításra. Az eszközt csak a megfelelő méret meghatározása után, elfogadott aszeptikus technika alkalmazásával vegye ki a csomagolásból. Ha a steril csomagolás sérültnek vagy véletlenül felbontott állapotúnak tűnik, ne használja fel a tartalmát.

ALKALMAZÁS SZERINTI FELHASZNÁLÓ

Ezeket az eszközöket kizárólag képzett szakemberek használhatják. Elengedhetetlen, hogy a sebész és a műtő személyzete alaposan ismerje az implantátummal kapcsolatos megfelelő sebészeti eljárást és az ehhez kapcsolódó eszközöket.

TERVEZETT FELHASZNÁLÁS (PÁCIENS CÉLCSOPORT)

Alkalmazási terület

Teljes csípő arthroplastica javallott a sérült csípőízület pótlására azoknál a betegeknél, akiknél megfelelő szilárdságú a csontállomány a komponensek elhelyezéséhez és megtámasztásához.

FIGYELMEZTETÉS: A DePuy moduláris femorális szárakkal csak DePuy moduláris femorális fejeket és DePuy acetabuláris komponenseket

használjon. A femorális fej külső átmérőjét egyeztetni KELL az acetabuláris komponens belső átmérőjével.

Cementált komponensek

Ez a „Kizárólag cementált felhasználásra” feliratú acetabuláris eszköz csontcementtel történő használatra szolgál.

BETEGPOPULÁCIÓ

Olyan kifejelett csontozatú betegpopuláció esetén javallott, ahol megfelelő szilárdságú a csontállomány a komponensek elhelyezéséhez és megtámasztásához.

JAVALLATOK

Teljes csípőprotézis beültetése a következő esetekben javallott:

1. Erős fájdalommal járó és/vagy gyulladt ízület (jellemzően nem gyulladásos degeneratív ízületi betegség miatt).
2. Sikertelen korábbi csípőműtét.
3. A femorális fej vagy a femorális nyak akut törése.

ELLENJAVALLATOK

Az alábbi állapotok a totál csípőprotézis beültetésének ellenjavallatát képezik:

1. Aktív lokális vagy szisztémás fertőzés.
2. Az izomzat mennyiségének csökkenése, neuromuszkuláris betegség vagy rossz vérellátás az érintett végtagban, ami a beavatkozás elvégzése ellen szól.
3. Rossz minőségű csontállomány, például osteoporosis esetén, amikor a sebész megítélése szerint a protézis jelentősen elmozdulhat, vagy nagy a veszélye a femorális szár törésének, és/vagy nem megfelelő minőségű a csontállomány az implantátum(ok) megtámasztásához.
4. Charcot–Marie–Tooth-betegség vagy Paget-kór.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELEM!

- Az implantátumokat soha nem szabad más gyártóktól származó, illetve más implantátumrendszerhez tartozó próbakomponensekkel együtt használni.
- A csípőprotézis komponenseit soha nem szabad újra beültetni. Előfordulhat, hogy ha még az implantátum sértetlennek is tűnik, kialakulhattak olyan mikroszkopikus hibák az implantátumban, amelyek annak elégtelenségéhez vezethetnek.
- Bepróbáláshoz minden esetben próbaprotézist használjon. A bepróbálásokat nem szabad állandó beültetésre szánt komponensekkel végezni. A próbáknak ugyanolyan konfigurációjúnak,

méretűnek stb. kell lenniük, mint a tartósan beültetésre kerülő adott komponenseknek.

- A DePuy által gyártott egyszer használatos eszközök az egy betegen történt egyszeri felhasználás után kialakításuknál fogva alkalmatlanok arra, hogy azokon bármilyen módosítást, például szétszerelést, tisztítást vagy újrasztelizálást hajtsanak végre. Az ismételt felhasználás potenciálisan veszélyeztetheti az eszköz teljesítményét és a beteg biztonságát.
- Semmiképp ne alakítsa át vagy módosítsa az implantátumokat a sebészeti módszertanban leírtakon kívül.
- A minőségi csontállomány elengedhetetlen ahhoz, hogy az eszköz rögzülhessen. Vegye figyelembe a csontátültetésre és az eszköz elhelyezésére és megtámasztására szolgáló egyéb erősítő módszereket is, főleg a revíziós műtétéknél.

FIGYELEM: Az alábbi állapotok önmagukban vagy együttesen jellemzően az érintett végtag jelentős megterheléséhez vezetnek, ezáltal növelik a páciens csípőprotézis-elégtelenségének kockázatát:

1. Elhízott vagy túlsúlyos páciens.
2. Fizikai munka.
3. Mérsékelttől a megterhelőig terjedő sporttevékenység.
4. A beteg nagyfokú aktivitása.
5. Esések nagy valószínűsége.
6. Alkohol- vagy kábítószer-függőség.
7. Egyéb releváns korlátozottságok.

FIGYELEM: Az alábbi állapotok önmagukban vagy együttesen jellemzően kedvezőtlenül befolyásolják a csípőimplantátum rögzülését:

1. Kifejezett osteoporosis vagy rossz minőségű csontállomány.
2. Az implantátum megtámasztását biztosító szilárd csontállomány progresszív leromlásához vezető anyagcsere-betegségek vagy szisztémás gyógyszeres kezelések (pl. diabetes mellitus, szteroidterápiák, immunszuppresszív terápiák stb.).
3. Az anamnézisben szereplő kiterjedt vagy lokális fertőzések.
4. Az implantátum hibás rögzüléséhez vagy nem megfelelő pozicionálásához vezető súlyos deformitások.
5. A megtámasztást biztosító csontképletek daganatai.
6. Az implantátum anyagai (pl. csontcement, fém) által kiváltott allergiás reakciók.
7. Az implantátum korróziója vagy az implantátum kopási törmelékei által kiváltott szövetreakciók.
8. Más ízületek (pl. térd és boka) mozgáskorlátozottsága.

MEGJEGYZÉS: Az esetlegesen fennálló cukorbetegség jelen állás szerint nem tekinthető ellenjavallatnak. Súlyos cukorbetegség esetén azonban a szövödmények, például fertőzés, lassú sebgyógyulás stb. fokozott kockázata miatt az orvosnak gondosan mérlegelnie kell, hogy mennyire tanácsos a csípőprotézis beültetése.

A páciens műtét alatti és utáni kezelését az összes fennálló állapot kellő mérlegelésével kell végezni. A páciens olyan mentális állapota vagy mentális betegsége, amely a sebészi utasítások be nem tartását eredményezi, késleltetheti a posztoperatív gyógyulást, és/vagy növelheti a nemkívánatos hatások kialakulásának kockázatát, például az implantátum vagy az implantátum rögzülésének elégtelenségét.

A túlzott fizikai aktivitás vagy a pótoltt ízületet ért trauma a csípőprotézis korai elégtelenségéhez vezethet azáltal, hogy az implantátumok helyzetének megváltozását, törését és/vagy kopását idézi elő.

VÁRHATÓ KLINIKAILAG KEDVEZŐ HATÁSOK

A teljes csípő arthroplastica várhatóan fokozza a páciens mobilitását, és csökkenti a fájdalmát azáltal, hogy pótolja a sérült csípőizületet azoknál az érett csontozatú pácienseknél, akiknek bizonyíthatóan megfelelő szilárdságú a csontállománya a komponensek elhelyezéséhez és megtámasztásához.

BIZTONSÁGOSSÁGRA ÉS KLINIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉGRE VONATKOZÓ ÖSSZEFOGLALÓ (SSCP)

Néhány országban vagy régióban csípőprotézis-nyilvántartásokat vezetnek, amelyekkel nyomon lehet követni a csípőimplantátumok teljesítményét. A nyilvántartásban szereplő adatokat elemezve azt találták, hogy általában a páciensek 95%-ánál (100-ból 95 páciensenél) az első teljes csípőprotézis beültetése 10 évnél tovább marad hatásos. Ez azt jelenti, hogy 10 évvel a műtét után a páciensek kb. 5%-ánál (100-ból 5 páciensenél) lehetett szükség további műtétekre, hogy eltávolítsák az implantátum egyes részét/részeit. Revíziós csípőprotézis beültetése esetén a protézis élettartama általában 80%-ban meghaladja a 10 évet. Ez az eszköz megfelel az általános implantátum-élettartamnak. Egy adott páciens esetében a revíziós műtét kockázata olyan betegspecifikus tényezőktől függ, mint például a páciens anatómiai felépítése, az egészségi állapota és életmódja (pl. súlya és aktivitási szintje), a sebészeti beavatkozás és az eljárás.

Az eszközspecifikus SSCP a következő linken érhető el:

<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Megjegyzés: Az Eudamed hivatkozás csak akkor lesz elérhető, ha az Eudamed adatbázis élesítésre kerül.

Súlyos rendkívüli események jelentése

Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint a felhasználó és/vagy a beteg lakhelye szerinti illetékes hatóságoknak.

Súlyos rendkívüli eseménynek számít minden olyan rendkívüli esemény, amely közvetlenül vagy közvetetten a következőkhöz vezetett, vezethetett volna vagy vezethet:

- a) a beteg, a felhasználó vagy más személy halála;
- b) a beteg, a felhasználó vagy más személy egészségi állapotának súlyos, átmeneti vagy maradandó romlása;
- c) súlyos népegészségügyi kockázat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Preoperatív időszak

A SEBÉSZNEK A MŰTÉT ELŐTT MEG KELL BESZÉLNI A BETEGGEL AZ ÖSSZES RÁ VONATKOZÓ FIZIKAI ÉS MENTÁLIS KORLÁTOZÁST, VALAMINT A MŰTÉTTEL ÉS A PROTÉZISEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT, MINDEN SZEMPONTBÓL. A megbeszélésnek ki kell térnie a korlátozásokra és az ízületpótlás lehetséges következményeire, valamint annak a szükségességére, hogy a műtétet követően a beteg betartsa a sebész utasításait, és kövesse a betegtájékoztatóban szereplő információkat.

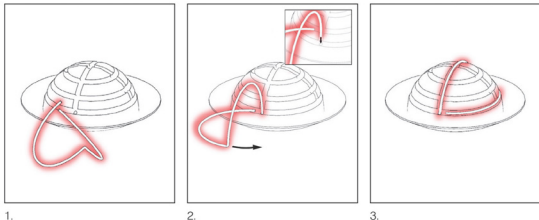
A csípőprotézis komponensek beültetéséhez szükséges preoperatív tervezési és műtéti technikák számos csípőprotézis-fejlesztés során szerzett sebészeti tapasztalatból alakultak ki. A sebésznek a specifikus beültetési technika alapos megismerése előtt nem szabad belekezdnie egyetlen csípőprotézis klinikai alkalmazásába sem. A műtéti technikát ismertető kiadványok a DePuy képviselőjétől szerezhetők be.

Műtéti időszak

Javasolt, hogy a műtét folyamán a preoperatív időszakban meghatározott méreteken kívül minden komponensből álljon rendelkezésre legalább egy számmal nagyobb és kisebb méret, hogy műtét közben lehetőség legyen a megfelelő méret(ek) kiválasztására.

A védőbevonatokat addig kell a komponenseken hagyni, amíg azok beültetésre kész állapotban nem lesznek. Ne használjon fel olyan komponenseket, amelyek leestek vagy kemény felülethez ütődtek. Még ha a komponens sérülése esetleg nem is látható, akkor is okozhatja a protézis korai elégtelenségét. A műtéti technikát ismertető kiadványban leírt sebészeti műszereket a jelen arthroplastikai eljárásra tervezték és a műtéti technikát ismertető kiadványban bemutatottaknak megfelelően kell használni.

Revíziós műtét esetén fontos a meghibásodott protézist borító összes rostos kötőszövet eltávolítása. A rostos kötőszöveti maradványok akadályozhatják az implantátum rögzülését. Vizsgálja felül a már meglévő eszközöket, hogy nem sérültek-e az egymáshoz kapcsolódó felszínnek, ami megakadályozhatja az új eszköz megfelelő elhelyezését vagy záródását. Az implantátumok nem megfelelő kiválasztása, behelyezése vagy pozicionálása szokatlan terhelési viszonyokat hozhat létre, ami az implantátum funkcionális élettartamának következményes csökkenésével járhat. Az acetabuláris komponens antevertíójának fokozása teljes csípőpótlás esetén instabilitást és/vagy ficamot eredményezhet. Sebzés előtt a műtéti területet alaposan meg kell tisztítani a csonttörmeléktől, a szövetek között lévő csontcementtől, ektópiás csonttól stb. A fém-műanyag vagy a kerámia-műanyag érintkezési felszínen lévő idegentestek túlzott kopást eredményezhetnek. A mozgástartományt alaposan ellenőrizni kell annak megállapítása érdekében, hogy megfelelő-e az eszközök kapcsolódása, illetve nem áll-e fenn instabilitás vagy becsípődés. Szükség esetén megfelelő korrekció végzendő.



Röntgenjelölő drótszerelék

Posztoperatív időszak

Kiemelkedően fontos, hogy a beteg szigorúan betartsa a sebész utasításait és figyelmeztetéseit. A posztoperatív gondozás időszakában az elfogadott gyakorlat szerint kell eljárni.

A beteget teljes körű írásos utasításokkal és figyelmeztetésekkel kell hazabocsájtani a kórházból, az elvégzendő testmozgásra, terápiákra és a tevékenységeket érintő bármilyen korlátozásra vonatkozóan. Az alkatrész nem megfelelő elhelyezése, illetve a csípő vagy a csípő összeszerelése moduláris szegélyű fejvel vagy kúpos hüvellyel csökkentheti az ízületi

mozgástartományt, és növelheti az alkatrész kopásának, behatásának, idő előtti kificamodásának vagy felülvizsgálatának lehetőségét. Ezekben az esetekben a sebésznek tájékoztatnia kell a beteget arról, hogy kerülnie kell a széles mozgástartományt igénylő tevékenységet.

Mivel az adott beteg esetében nem ismert az implantátum funkcionális élettartama, folyamatos, időszakos utógondozás ajánlatos, különös tekintettel az implantátum rögzítéseire és illeszkedő felületeire. Minden egyes utógondozási alkalommal radiológiai vizsgálatokat kell végezni, az eredményeket összevetve a korábbi radiológiai vizsgálatokkal, és korreláltatva a beteg klinikai értékelésével. Ha bármilyen radiológiai eltérés mutatkozik, például fokozott transzparencia, csontfelszívódás vagy az implantátum helyzetében bekövetkező bármilyen változás, akkor ez gondos ellenőrzést igényel annak megállapítása érdekében, hogy ezek a változások statikus vagy progresszív természetűek-e, és a páciens megfelelő terápiában kell részesíteni.

NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK ÉS SZÖVŐDMÉNYEK

Csípőprotézis beültetése során általában az alábbi nemkívánatos események és szövődmények fordulnak elő a leggyakrabban:

Általános

Csípőprotézis beültetése során a szövődmények előfordulási gyakorisága és súlyossága általában nagyobb a revíziók során, mint az elsődleges műtétek esetében. Revíziós műtétek során gyakran előforduló problémák: a bõrmetszés helyének kiválasztásával kapcsolatos nehézségek, az ektópiás csont és a régi csontcement eltávolítása, a komponensek pozicionálása és rögzítése és/vagy megfelelő csontos megtámasztás biztosítása. Általánosságban elmondható, hogy revíziós beavatkozásoknál megnövekedett műteti időre és vérvesztésre, valamint a fertőzés, tüdőembólia és sebhematóma fokozott kockázatára lehet számítani.

Általános

1. A protézis komponensek helyzetének megváltozása, amely gyakran a FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK részben felsorolt tényezőkkel kapcsolatos.
2. A protézis komponensek korai vagy késői kilazulása, amely gyakran a FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK részben felsorolt tényezőkkel kapcsolatos.
3. A femorális szár vagy a vápakomponens fáradásos törése, amely gyakran a FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK részben felsorolt tényezőkkel kapcsolatos.

4. A tartó komponensek túlzott kopása vagy törése a következő állapot miatt: a protézis komponensek műtét közbeni károsodása, levált cement- és csontszilánkok, fémrészecskék, kerámia részecskék vagy más, a FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK részben felsorolt tényezők.
5. Korai vagy késői fertőzés.
6. Perifériás neuropathia. Műtéti trauma következtében történt szubklinikai idegsérülés.
7. Szöveti reakciók, osteolysis és/vagy az implantátum kilazulása fémmkorrózió, allergiás reakciók, kopás vagy szemcsés törmelék (mint például levált cement-, fém-, polietilén- vagy kerámiarészecskék) miatt.
8. Visszamaradó fájdalom a csípőben.

Műtéti időszak

1. A femorális szár vagy az acetabuláris rész perforációja, repedése vagy törése, amely belső rögzítést tehet szükségessé.
2. Trochantertörés.
3. Érkárosodás (pl. arteria iliaca, a. obturatoria és a. femoralis).
4. Átmeneti vagy maradandó idegkárosodás (pl. n. femoralis, n. obturatorius vagy izolált n. peroneus sérülése).
5. Az implantátum választott méretéből vagy konfigurációjából, illetve a komponensek pozicionálásából és/vagy izom- és kötőszöveti lazaságból fakadó csípőízületi szubluxáció vagy ficam.
6. Az érintett végtag hosszabbodása vagy rövidülése.
7. A műtét időpontjának kitolása.

Korai posztoperatív időszak

1. Szív- és érrendszeri rendellenességek, például vénás trombózis, tüdőembólia és miokardiális infarktus.
2. Hematóma és/vagy elhúzódó sebgyógyulás.
3. Szubluxáció vagy ficam.
4. A moduláris komponensek szétválása.

Kései posztoperatív időszak

1. A trochanter leszakadása túlzott izomfeszülés, súlyterhelés vagy a trochanter véletlen intraoperatív meggyengítése miatt;
2. Az azonos, illetve ellenoldali térd- és bokaízületi problémák súlyosbodása az alsó végtag hosszkülönbsége, a femur medializációja és/vagy izomdefektusok miatt.
3. Acetabuláris vagy femorális törés trauma vagy túlterhelés miatt, különösen súlyos osteoporosis, előző műtétből eredő csontdefektusok, intraoperatív felfúrások vagy csontfelszívódás okozta csökkent saját csontállomány esetén.

4. Csontreszorpció, amely hozzájárulhat a rögzítés elégtelenné válásához és idővel az implantátum kilazulásához.
5. Az ízület mobilitásának csökkenése és mozgástartományának beszűkülése (pl. periarticularis meszesedés vagy csontosodás által okozott).
6. Az azonos oldali térd traumás arthrosis a végtag műtét alatti pozicionálása miatt.
7. Szubluxáció vagy ficam.
8. A moduláris komponensek szétválása.

MR-BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



MR-biztonsági információk

A DePuy MARATHON™ XLPE cementezett csípővápa-protézis szerkezettel rendelkező páciensen a következő feltételek mellett lehet MR-vizsgálatot végezni. A feltételek be nem tartása a beteg sérülését okozhatja.

Az eszköz neve/azonosítója	MARATHON XLPE cementezett csípővápa-protézis
A statikus mágneses mező névleges értéke(i) [T]	1,5 T vagy 3,0 T
Maximális térbeli gradiens [T/m és gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
RF gerjesztés	Körkörösén polarizált (CP)
RF adótekercs típusa	Teljes testes adótekercs, RF adó-vevő fejtekercs
Üzem mód	Normál üzemmód
Maximális teljes test	2,0 W/kg (normál üzemmód)
Maximális fej SAR	Fejtekercs használata nem szükséges a csípő vizsgálata során.
A vizsgálat időtartamára vonatkozó korlátozások	2,0 W/kg teljes testre átlagolt SAR. A vizsgálat legfeljebb 15 percig tarthat, majd 15 perces lehűlési időszaknak kell követnie (egyetlen képalkotási munkameneten belül legfeljebb háromszor ismételhető meg).

MR-felvételen keletkező műtermék	Az implantátum jelenléte várhatóan nem eredményez 108 mm-nél nagyobb kiterjedésű képi műterméket.*
Az MR-környezetben való biztonságos használathoz szükséges további utasítások vagy információk.	* Ellenőrizze a csípőszerkezet minden komponensét és győződjön meg arról, hogy nem tartalmaznak MR-címkézéssel feltüntetett további információkat.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Minden eszközt a helyi eljárásoknak és irányelveknek megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítson.

It

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

„MARATHON™ XLPE“ cementinis kaušelis

SVARBI INFORMACIJA – perskaitykite prieš naudodami

Kai kurie produktai gali būti licencijuoti ne visose jurisdikcijose.



STERILE

Metodas nurodytas gaminio etiketėje

Naudojimo instrukcijų svetainė

Norėdami pasiekti elektroninę naudojimo instrukciją ir kitas kalbas, apsilankykite adresu www.e-IFU.com

Implanto kortelė, paciento informacinis lapelis (PIL) ir interneto svetainė

Implanto kortelė (ir implanto kortelės etiketė) yra pakuotėje su implantu. Informacija paciento informaciniame lapelyje (PIL) grindžiama šiose naudojimo instrukcijose pateikta informacija. Toliau nurodytoje svetainėje galima rasti ePIL.

Jei reikia elektroninio PIL, apsilankykite adresu www.ic.injmedicaldevices.com

PRIETAISO APRAŠAS

Tai ypač didelio molekulinio svorio polietileno (UHMWPE) gūžduobės komponentas su metaliniais rentgeno žymekliu laidais. Viso klubo sąnario protezą sudaro atskirai supakuoti komponentai: metalinis šlaunikaulio klubo pagrindas, modulinė metalinė arba keraminė šlaunikaulio galva ir 2 dalių

gūžduobės komponentai iš ypač didelio molekulinio svorio polietileno (UHMWPE) su metaline galine dalimi, keramikos arba tik iš UHMWPE. Visi šie komponentai sukurti natūraliam sąnario paviršiui pakeisti.

MEDŽIAGOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS

Toliau pateiktoje informacijoje nurodomos implanto medžiagos. Dėl gamybos proceso gali būti papildomų kitų medžiagų pėdsakų. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės toliau pateiktu adresu.

Šis prietaisas yra konstrukcija, pagaminta iš ypač didelio molekulinio svorio polietileno (97–99 % m/m) titano lydinio (1–2 % m/m) ir nerūdijančiojo plieno lydinio (mažiau nei 1 % m/m), priklausomai nuo dydžio.

Etiketėje (-ėse) esančios santrumpos pavyzdys	Medžiagos aprašymas	Įprasta medžiagos sudėtis
PE, UHMWPE, P1	Ypač didelio molekulinio svorio polietilenas	Polietilenas (100 %)
T1, Ti1	Titano lydinys	Titanas (90 %) Aliuminis (6 %) Vanadis (4 %)
S2, SS2	Nerūdijančiojo plieno lydinys (316L)	Geležis (62 %) Chromas (18 %) Nikelis (14 %) Molibdenas (3 %) Manganas (2 %)

KAIP TIEKIAMA

Šios priemonės supakuotos atskirai ir tiekiamos STERILIOS. Tik parinkę tinkamą dydį, išimkite iš pakuotės taikydami aseptikos metodus. Jei sterili pakuotė atrodo pažeista arba netyčia atidaryta, šių komponentų nenaudokite.

NUMATYTASIS NAUDOTOJAS

Šių prietaisų negali naudoti nekvalifikuoti darbuotojai. Labai svarbu, kad chirurgas ir operacinės personalas išmanytų implantui ir susijusiems instrumentams taikomus tinkamus chirurgijos metodus.

PASKIRTIS (TIKSLINĖ PACIENTŲ GRUPĖ)

Paskirtis

Viso klubo sąnario artroplastika skirta pažeistam klubo sąnariui pakeisti pacientams, jei yra įrodymų, kad pakanka sveiko kaulo komponentams įstatyti ir palaikyti.

ĮSPĖJIMAS. Su „DePuy“ moduliniais šlaunikaulio pagrindais naudokite tik „DePuy“ modulines šlaunikaulio galvutes ir „DePuy“ gūžduobės komponentus. Išorinis šlaunikaulio galvos skersmuo TURI būti suderintas su gūžduobės komponento vidiniu skersmeniu.

Cementuojami komponentai

Šis gūžduobės prietaisas, pažymėtas užrašu „For cemented use only“ (naudoti tik su cementu), skirtas naudoti su kaulų cementu.

PACIENTŲ POPULIACIJA

Numatytoji pacientų populiacija yra subrendusio skeleto žmonės, jei yra įrodymų, kad pakanka sveiko kaulo komponentams įstatyti ir palaikyti.

INDIKACIJOS

Viso klubo sąnario pakeitimo indikacijos

1. Stiprus sąnario skausmas ir (arba) sąnario artritas (paprastai dėl su uždegimu nesusijusios degeneracinės sąnarių ligos)
2. Nepavykusi ankstesnė klubo operacija
3. Ūminis šlaunikaulio galvos ar kaklo lūžis

KONTRAINDIKACIJOS

Viso klubo sąnario pakeitimo kontraindikacijos

1. Aktyvi vietinė ar sisteminė infekcija
2. Raumenų nykimas, nervų ir raumenų pažeidimas arba kraujotakos nepakankamumas pažeistoje galūnėje, dėl kurių negalima atlikti procedūros
3. Bloga kaulo kokybė, pvz., osteoporozė, dėl kurios, chirurgo nuomone, galimas didelis protezo judėjimas, didelė šlaunikaulio kūno lūžio rizika ir (arba) nepakanka kaulo implantui (-ams) išlaikyti
4. Šarko (Charcot) arba Pedžeto (Paget) liga

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

PERSPĖJIMAS

- Niekada kartu nenaudokite skirtingų gamintojų implantų ir bandomųjų komponentų ar implantų sistemų.
- Klubo protezo komponentų jokiais atvejais negalima implantuoti iš naujo. Nors implantas atrodo nepažeistas, jame gali būti mikroskopinių defektų, kurie gali sukelti funkcionalumo sutrikimą.

- Bandymo tikslais visada naudokite bandomąjį protezą. Bandomųjų komponentų negalima montuoti su jokiais komponentais, skirtais implantuoti visam laikui. Bandomieji komponentai turi būti tokio paties dydžio, konfigūracijos ir pan., kaip atitinkami komponentai, kurie bus implantuoti visam laikui.
- Kartą vienam pacientui panaudotos šios vienkartinės „DePuy“ pagamintos priemonės negali būti kaip nors keičiamos, pvz., ardamos, valomos ar pakartotinai sterilizuojamos. Pakartotinai naudojant galima pabloginti priemonės veiksmingumą ir pakenkti paciento saugumui.
- Jokių būdų nekeiskite ir nemodifikuokite implantų, jei tai nenurodyta chirurginės metodikos vadove.
- Siekiant užtikrinti prietaiso fiksavimą labai svarbu, kad sveiko kaulo atsargos būtų pakankamos. Apsvarstykite kaulo persodinimą ir kitus sutvirtinimo būdus, ypač atlikdami revizines operacijas, kad būtų galima priemonę įstatyti ir ji būtų palaikoma.

PERSPĖJIMAS. Toliau nurodytomis sąlygomis (pavieniui ar tuo pačiu metu) susidaro didelė pažeistos galūnės apkrova, todėl kyla didesnis pavojus, kad pakeisto klubo sąnario funkcionalumas sutriks.

1. Nutukimas arba per didelis paciento svoris
2. Fizinis darbas
3. Užsiėmimas vidutinės ar didelės fizinės ištvermės reikalaujančiu sportu
4. Didelis paciento aktyvumas
5. Kritimų tikimybė
6. Priklausomybė nuo alkoholio ar narkotikų
7. Kito pobūdžio negalia, jei yra

PERSPĖJIMAS. Toliau nurodytos sąlygos (atskirai arba vienu metu) pablogina klubo sąnario implantų fiksaciją.

1. Stipri osteoporozė ar prastos kaulo atsargos
2. Medžiagų apykaitos sutrikimai ar sisteminis farmakologinis gydymas, dėl kurio laipsniškai blogėja kietojo kaulo atrama, reikalinga implantui (pvz., cukrinis diabetas, gydymas steroidais, imunosupresantais ir kt.)
3. Ankstesnės bendrosios ar vietinės infekcijos
4. Sunkios deformacijos, dėl kurių sutrinka implanto fiksacija arba neįmanoma tinkama implanto padėtis
5. Atraminų kaulų struktūrų navikai
6. Alerginės reakcijos į implanto medžiagas (pvz., kaulų cementą, metalą)
7. Audinių reakcijos į implanto koroziją ar implanto susidėvėjimo nuolaužas
8. Kitų sąnarių (t. y. kelių ir kulkšnių) defektai

PASTABA. Šiuo metu diabetas nėra laikomas kontraindikacija. Tačiau dėl padidėjusio komplikacijų, pvz., infekcijų, lėto žaizdų gijimo ir kt., pavojaus

gydytojas turi atidžiai apsvarstyti, ar sunkiai cukriniu diabetu sergančiam pacientui galima keisti klubo sąnarį.

Chirurginis ir pooperacinis paciento gydymas turi būti parinktas tinkamai atsižvelgiant į visas esamas sąlygas. Jei dėl mąstymo ar psichinių sutrikimų pacientas nesilaiko chirurgo nurodymų, pooperacinis sveikimas gali trukti ilgiau ir (arba) gali padidėti nepageidaujamų reiškinių, įskaitant implanto funkcionalumo sutrikimą ar netinkamą implanto fiksavimą, rizika.

Per didelės fizinės aktyvumas ar pakeisto sąnario trauma gali lemti ankstyvą pakeisto klubo sąnario funkcionalumo sutrikimą, nes implantas gali pakeisti padėtį, sulūžti ir (arba) susidėvėti.

NUMATOMA KLINIKINĖ NAUDA

Viso klubo sąnario artroplastikos tikslas yra padidinti paciento mobilumą ir sumažinti skausmą, pakeitus pažeistą klubo sąnarį pacientui, kurio skeletas subrendęs, jei yra įrodymų, kad pakanka sveiko kaulo komponentams įstatyti ir palaikyti.

SAUGOS IR KLINIKINIO VEIKSMINGUMO DUOMENŲ SANTRAUKA

Kai kuriose šalyse ar regionuose veikia klubo sąnarių implantų registrai. Juose kaupiama informacija leidžia stebėti klubo sąnario implantų veiksmingumą. Šių registrų duomenų analizė parodė, kad pirmą kartą keičiant visą klubo sąnarį paprastai 95 % (95 iš 100) pacientų jis tarnauja ilgiau kaip 10 metų. Tai reiškia, kad per 10 metų apytiksliai 5 % (5 iš 100) pacientų gali reikėti papildomos operacijos vienai ar daugiau dalių pašalinti. 80 % atvejų revizinis klubo sąnario protezas tarnauja daugiau nei 10 metų. Šis prietaisas atitinka šią implanto naudojimo trukmę. Ar individualiam pacientui reikės revizinės operacijos, lemia konkretūs pacientui būdingi veiksniai, pvz., anatomicinės ypatybės, sveikatos būklė ir gyvenimo būdas (pvz., svoris ir aktyvumo lygis), chirurginės procedūros atlikimas ir procesas. Konkrečios priemonės saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santrauką rasite svetainėje <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Pastaba. „Eudamed“ nuoroda bus pasiekama tik tada, kai pradės veikti „Eudamed“ duomenų bazė.

Pranešimas apie rimtus incidentus

Apie visus rimtus su priemone susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje dirba naudotojas ir (arba) gyvena pacientas, kompetentingai institucijai.

Rimtas incidentas – bet koks incidentas, tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlęs, galėjęs arba galintis sukelti bet kurią iš šių pasekmių:

a) paciento, naudotojo ar kito asmens mirtį;

- b) laikiną arba ilgalaikį paciento, naudotojo ar kito asmens sunkų sveikatos būklės pablogėjimą;
- c) rimtą grėsmę visuomenės sveikatai.

NAUDOJIMO INFORMACIJA

Prieš operaciją

CHIRURGAS PRIEŠ OPERACIJĄ SU PACIENTU TURI APTARTI VISUS FIZINIUS IR PSICHOLOGINIUS APRIBOJIMUS, SUSIJUSIUS SU PACIENTU, TAIP PAT VISUS OPERACIJOS BEI PROTEZŲ ASPEKTUS. Reikia aptarti su sąnario pakeitimu susijusius apribojimus bei galimas pasekmes, būtinybę laikytis chirurgo nurodymų po operacijos ir paciento informaciniame lapelyje pateiktą informaciją.

Šių klubo sąnario protezo komponentų ikioperacinis planavimas ir implantavimo chirurginiai metodai paremti chirurgine patirtimi, sukaupia kuriant daugybę klubo sąnario protezų. Chirurgai negali pradėti klinikinio klubo sąnario protezavimo, kol įgus taikyti specifinę implantavimo metodiką. Chirurginės metodikos brošiūrų galite gauti kreipęsi į „DePuy“.

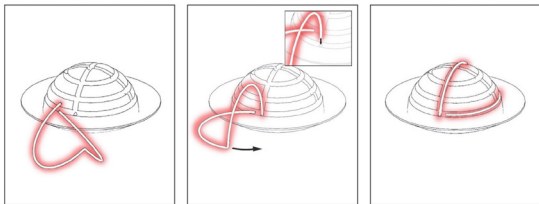
Operacijos metu

Rekomenduojama operuojant turėti komponentus, kurie bent vienu dydžiu didesni ir vienu dydžiu mažesni už pasirinktus prieš operaciją, kad operuojant būtų galima pasirinkti tinkamą dydį.

Apsauginiai dangčiai turi likti nenuimti, kol bus pasiruošta implantuoti komponentus. Nenaudokite komponentų, jei jie buvo numesti arba atsitrėkę į kietą paviršių. Net jei nematyti komponento pažeidimo požymių, protezo funkcionalumas gali sutrikti per anksti. Chirurginės technikos brošiūroje nurodyti chirurginiai instrumentai sukurti šiai artroplastikos procedūrai ir turi būti naudojami taip, kaip nurodyta chirurginės technikos brošiūroje.

Atliekant revizinę operaciją, būtina pašalinti visas skaidulines plėves, gaubiančias netinkamai veikiančią protezą, kuris bus visas pašalintas. Pluoštinių membranų likučiai gali trukdyti implanto fiksacijai. Apžiūrėkite, ar nepažeisti jau implantuotų priemonių kontaktiniai paviršiai, nes tai trukdytų tinkamai įstatyti ar užfiksuoti naują priemonę. Netinkamas implantų pasirinkimas, įdėjimas ar netinkama jų padėtis gali sukelti neįprastas apkrovos sąlygas, dėl to gali sutrumpėti implanto naudojimo laikotarpis. Padidėjus gūžduobės komponento antversijai pakeitus visą klubą, gali atsirasti nestabilumas ir (arba) dislokacija. Prieš užsiuvant iš operuojamos vietos reikia kruopščiai pašalinti kaulų nuolaužas, kaulų cemento perteklių, ectopinį kaulą ir kt. Svetimkūniai metalo ir plastiko arba keramikos ir plastiko lietimosi srityse gali lemti smarkų susidėvėjimą. Būtina atidžiai

patikrinti judėjimo amplitudę ir įvertinti, ar komponentai susijungia tinkamai, yra stabilūs, nėra kliūčių. Jei reikia, pataisykite.



1.

2.

3.

Rentgeno žymeklio laidų mazgas

Po operacijos

Itin svarbu, kad pacientas griežtai laikytųsi chirurgo nurodymų ir įspėjimų. Pooperacinė paciento priežiūra turi atitikti patvirtintą praktiką.

Išleidžiant iš ligoninės pacientui reikia pateikti išsamius rašytinius nurodymus ir įspėjimus apie mankštą, gydymą ir bet kokius aktyvumo apribojimus. Netinkama komponento padėtis arba suvaržyto klubo ar viso klubo sąnario naudojimas su moduline šalia briaunos esančia galvute arba kūgine mova gali sumažinti sąnario judesių amplitudę ir padidinti komponentų nusidėvėjimo, ankštumo, ankstyvos dislokacijos ar revizijos tikimybę. Tokiais atvejais chirurgas turi informuoti pacientą, kad reikia vengti veiklos, kuriai reikalingi didelės amplitudės judesiai.

Rekomenduojama nuolat stebėti pacientą, nes nežinoma, kaip ilgai funkcionuos konkretaus paciento implantas, ypač atsižvelgiant į implanto fiksavimą ir atraminių paviršių išlaikymą. Radiologinius tyrimus reikia atlikti kiekvieno stebėjimo vizito metu, juos reikia palyginti su anksčiau gautais radiologiniais vaizdais ir susieti su paciento klinikinio įvertinimu. Pastebėjus radiologinių pokyčių, pvz., pralaidumą spindulinei energijai, kaulų rezorbciją ar implanto padėties pasikeitimą, reikia atidžiai stebėti ir nustatyti, ar pokyčiai nekintami ar progresuojantys, ar pacientas tinkamai gydomas.

NEPAGEIDAUJAMI REIŠKINIAI IR KOMPLIKACIJOS

Toliau išvardyti paprastai dažniausi nepageidaujami reiškiniai ir komplikacijos, atlikus klubo sąnario artroplastiką.

Bendrieji

Klubo sąnario pakeitimo komplikacijų dažnis ir sunkumas paprastai būna didesnis atliekant revizines, o ne pirmines operacijas. Atliekant revizinę operaciją, dažnai susiduriama su tokiomis problemomis kaip sunkumai prapjaunant, ektopinio kaulo ir seno kaulų cemento pašalinimas, komponentų padėtis bei fiksavimas ir (arba) tinkamos kaulinės atramos užtikrinimas. Apskritai, atliekant revizines procedūras, galima tikėtis, kad operacija truks ilgiau, pacientas neteks kraujo, kils infekcija, plaučių embolija ir žaizdos hematomos pavojus.

Bendrieji

1. Protezo komponentų padėties pokyčiai, dažnai susiję su veiksniais, išvardytais skirsnyje ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
2. Ankstyvas ar vėlyvas protezo komponentų atsilaisvinimas, dažnai susijęs su veiksniais, išvardytais skirsnyje ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
3. Šlaunikaulio pagrindo ar taurelės komponento lūžis dėl nuovargio, dažnai susijęs su veiksniais, išvardytais skirsnyje ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
4. Pernelyg didelis atraminių komponentų nusidėvėjimas ar lūžimas dėl protezų komponentų pažeidimo operuojant, biraus cemento, kaulų fragmentų, metalinių ar keramikos dalelių, kitų veiksmų, išvardytų skirsnyje ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
5. Ankstyva ar vėlyva infekcija
6. Periferinės neuropatijos; dėl chirurginės traumos taip pat gali išsivystyti subkliniškas nervų pažeidimas
7. Audinių reakcijos, osteolizė ir (arba) implanto atsilaisvinimas dėl metalo korozijos, alerginių reakcijų, nusidėvėjimo arba pašalinių dalelių (pvz., biraus cemento, metalinių, polietilieninių ar keraminių dalelių)
8. Liekamasis klubo skausmas

Operaciniai

1. Šlaunikaulio pagrindo ar gūžduobės perforacija, įplėšimas ar lūžis, dėl kurio gali reikėti vidinės fiksacijos
2. Gūbrinis lūžis
3. Kraujagyslių pažeidimas (pvz., klubinės, užtvarinės ir šlaunikaulio arterijų)
4. Laikinas ar nuolatinis nervų pažeidimas (pvz., šlaunikaulio, užtvarinio ar atskiras šėvinio nervo)
5. Klubo sąnario dalinis išnirimas ar dislokacija dėl pasirinkto implanto dydžio ar konfigūracijos, komponentų padėties ir (arba) raumenų bei pluoštinių audinių atsipalaidavimo
6. Pažeistos galūnės pailgėjimas ar sutrumpėjimas
7. Būtinybė atidėti operaciją

Ankstyvieji pooperaciniai

1. Širdies ir kraujagyslių sutrikimai, įskaitant venų trombozę, plaučių arterijos emboliją ir miokardo infarktą
2. Hematoma ir (arba) ilgesnis žaizdų gijimas
3. Dalinis išnirimas arba dislokacija
4. Modulinių komponentų atskyrimas

Vėlyvieji pooperaciniai

1. Gūbrio avulsija dėl pernelyg didelio raumenų įsitempimo, svorio išlaikymo ar netyčinio gūbrio susilpninimo per operaciją
2. Ipsilateralinių ar kontralateralinių kelio ir kulkšnies sąnarių problemų sustiprėjimas dėl nevienodo kojų ilgio, šlaunikaulio medializacijos ir (arba) raumenų silpnumo
3. Gūžduobės ar šlaunikaulio lūžis dėl traumos ar per didelio krūvio, ypač jei kaulo atsargos prastos dėl sunkios osteoporozės, kaulų defektų po ankstesnės operacijos, plėtimo atliekant operaciją ar kaulų rezorbcijos
4. Kaulų rezorbcija, kuri gali pabloginti fiksaciją ir sukelti implanto atsilaisvinimą
5. Sumažėjęs sąnario judrumas ir judesių amplitudė (pvz., dėl periartikulinės kalcifikacijos ar kaulėjimo).
6. Trauminė ipsilateralinio kelio artrozė dėl antrinės galūnės padėties operacijos metu
7. Dalinis išnirimas arba dislokacija
8. Modulinių komponentų atskyrimas

MRT SAUGOS INFORMACIJA

 MRT saugos informacija Pacientą, kuriam implantuotas „DePuy MARATHON™“ XLPE cementinės gūžduobės klubo sąnario protezas, galima skenuoti toliau nurodytomis sąlygomis. Nesilaikant šių sąlygų, pacientą galima sužaloti.	
Prietaiso pavadinimas / identifikacija	„MARATHON XLPE“ cementinio kaušelio klubo sąnario protezas
Vardinė statinio magnetinio lauko vertė (T)	1,5 T arba 3,0 T
Didžiausias erdvinio lauko gradientas (T/m ir G/cm)	30 T/m (3 000 G/cm)*
RD sužadinimas	Apskritai poliarizuotas (CP)

RD perdavimo ritės tipas	Viso kūno perdavimo ritė, galvos RD perdavimo ir priėmimo ritė
Veikimo režimas	Įprastas veikimo režimas
Didžiausia viso kūno	2,0 W/kg (įprastu veikimo režimu)
Didžiausia galvutės vidutinė savitoji sugerties sparta (SAR)	Skenuojant klubo sąnarį šlaunikaulio galvutės ritės naudoti nereikia
Nuskaitymo trukmės apribojimai	2,0 W/kg viso kūno vidutinė SAR. Skenuokite iki 15 minučių, po to 15 minučių atvėsinkite (gali būti pakartota iki trijų kartų per vieną vaizdinio tyrimo seansą)
MR vaizdo artefaktas	Tikimasi, kad dėl šio implanto susidarantis vaizdo artefaktas neišsiplės daugiau kaip 108 mm.*
Papildomos instrukcijos arba informacija, būtina norint saugiai naudoti MR aplinkoje.	* Patikrinkite visus klubo sąnario konstrukcijos komponentus, ar nėra papildomos MR ženklinimo informacijos.

IŠMETIMAS

Visas panaudotas priemonės išmeskite saugiai, laikydamiesi vietos procedūrų ir gairių.

IV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MARATHON™ XLPE gūžas endoprotėze ar cementėjamu kausiņu

SVARĪGA INFORMĀCIJA — lūdzu, izlasiet pirms lietošanas

Daži produkti var nebūt licencēti visās jurisdikcijās.



STERILE

Metodi skatiet uz izstrādājuma etiķetes

Lietošanas instrukcijas (LI) tīmekļa vietnē

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijas elektroniskajai versijai un skatītu to citās valodās, apmeklējiet vietni www.e-IFU.com

Implanta karte, pacienta informācijas brošūra (PIB) un tīmekļa vietne

Implanta karte (un implanta kartes etiķete) ir iekļauta implanta iepakojumā. Pacienta informācijas brošūra ir balstīta uz informāciju šajā lietošanas instrukcijā. Elektroniskā pacienta informācijas brošūra ir atrodama tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.

Lai piekļūtu izstrādājuma informācijas brošūras elektroniskajai versijai, apmeklējiet vietni www.ic.jnjmedicaldevices.com

IERĪCES APRAKSTS

Šis ir īpaši augstas molekulmasas polietilēna (UHMWPE) acetabulārs komponents ar rentgenogrāfijas marķieriem – metāla stieplēm. Pilna gūžas locītavas endoprotēze sastāv no atsevišķi iepakotas metāla femorālās gūžas locītavas kājiņas, modulāras metāla vai keramikas femorālās galviņas un divdaļīgiem īpaši augstas molekulmasas polietilēna (UHMWPE) ar metāla pamatni, keramikas vai tikai UHMWPE acetabulārajiem komponentiem, kas paredzēti dabīgās gūžas locītavas artikulējošās virsmas aizvietošanai.

MATERIĀLI UN IEROBEŽOTA LIETOJUMA VIELAS

Tālāk sniegtajā informācijā ir uzskaitītas vielas, ko satur implants. Ražošanas procesa dēļ tas nelielā daudzumā var saturēt citas vielas. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto adresi.

Šis ierīces atkarībā no izmēra ir izgatavotas no īpaši augstas molekulmasas polietilēna (97–99 % masas), titāna sakausējuma (1–2 % masas) un nerūsējošā tērauda sakausējuma (mazāk nekā 1 % masas).

Uz etiķetes(-ēm) izmantotā akronīma piemērs:	Materiāla apraksts:	Materiāls nomināli satur šādas vielas:
PE, UHMWPE, P1	Īpaši augstas molekulmasas polietilēns	Polietilēns (100 %)
T1, Ti1	Titāna sakausējums	Titāns (90 %) Alumīnijs (6 %) Vanādijs (4 %)
S2, SS2	Nerūsējošā tērauda sakausējums (316L)	Dzelzs (62 %) Hroms (18 %) Niķelis (14 %) Molibdēns (3 %) Mangāns (2 %)

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

Šī/šīs ierīce(-es) tiek iepakota(-as) atsevišķi un piegādāta(-as) STERILA(-AS). Izņemiet no iepakojuma, izmantojot pieņemtu aseptisku metodi, tikai pēc tam, kad ir noteikts pareizais izmērs. Nelietot šos komponentus, ja sterlais iesaiņojums izskatās bojāts vai nejauši atvērts.

PAREDZĒTAIS LIETOTĀJS

Šīs ierīces nedrīkst izmantot nekvalificēts personāls. Ir svarīgi, lai ķirurgs un operāciju zāles personāls būtu apguvuši ar implantu un attiecīgiem instrumentiem saistītās ķirurģiskās metodes.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS (PACIENTU MĒRĶA GRUPA)

Paredzētais lietojums

Pilnīga gūžas artroplastija ir paredzēta bojātās gūžas locītavas artikulējošās virsmas aizvietošanai pacientiem, ja ir pierādījumi tam, ka ir pietiekami daudz pamatkaula, lai ievietotu un nostiprinātu komponentus.

BRĪDINĀJUMS. Ar DePuy modulārajām femorālajām kājiņām izmantojiet tikai DePuy modulāras femorālās galviņas un DePuy acetabulāros komponentus. Femorālās galviņas ārējam diametram JĀSAKRĪT ar acetabulārā komponenta iekšējo diametru.

Cementētie komponenti

Šī acetabulārā ierīce ar marķējumu "Paredzēta tikai lietošanai ar cementu" ir paredzēta lietošanai kopā ar kaulu cementu.

PACIENTU POPULĀCIJA

Paredzētā pacientu populācija ir pacienti ar nobriedušu skeletu, ja ir pierādījumi tam, ka ir pietiekami daudz pamatkaula, lai ievietotu un nostiprinātu komponentus.

INDIKĀCIJAS

Pilna gūžas locītavas endoprotezēšana ir indicēta tālāk norādītajos apstākļos.

1. Ļoti sāpīga un/vai artrītiska locītava (parasti to izraisa neiekaisīga degeneratīva locītavu slimība).
2. Nesekmīga iepriekšēja gūžas operācija.
3. Akūts femorālās galviņas vai kakliņa lūzums.

KONTRINDIKĀCIJAS

Tālāk ir norādītas kontrindikācijas pilnīgai gūžas locītavas endoprotezēšanai.

1. Aktīva lokāla vai sistēmiska infekcija.
2. Muskulatūras zudums, neiromuskulārs bojājums vai apasiņošanas nepietiekamība skartajā ekstremitātē, kas padara procedūru nepamatotu.
3. Slikta kaula kvalitāte, piemēram, osteoporoze, ja ķirurga skatījumā varētu būt ievērojama endoprotēzes migrācija vai femorālās vārpstas

lūzumu iespējamība un/vai adekvāta kaula masas atbalsta trūkums implantam(-iem).

4. Šarko vai Pedžeta slimība.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UZMANĪBU!

- Dažādu ražotāju vai implantu sistēmu implantus un izmēģinājuma komponentus nekādā gadījumā nedrīkst lietot kopā.
- Gūžas locītavu endoprotēzes komponentus nekādā gadījumā nedrīkst implantēt atkārtoti. Lai gan implants šķiet nebojāts, implantam var būt izveidojušies mikroskopiski bojājumi, kas var izraisīt neveiksmi.
- Vienmēr izmēģinājuma nolūkos izmantojiet paraugprotēzi. Paraugprotēzes nedrīkst salikt no komponentiem, kas paredzēti pastāvīgai implantēšanai. Paraugprotēzēm jābūt tādai pašai konfigurācijai, izmēram u. c. kā attiecīgajiem pastāvīgi implantētajiem komponentiem.
- DePuy vienreizējās lietošanas ierīcēm pēc vienreizējas izmantošanas nedrīkst veikt nekādus pārveidojumus, piemēram, izjaukšanu, tīrīšanu vai atkārtotu sterilizēšanu. Atkārtota lietošana var pasliktināt ierīces veiktspēju un apdraudēt pacientu.
- Nekādā veidā nemainiet un nepārveidojiet implantus, ja vien attiecīga pārveidošana nav aprakstīta ķirurģiskās metodes rokasgrāmatā.
- Kvalitatīva kaulviela ir būtiska, lai nodrošinātu ierīces fiksāciju. Apsveriet kaula transplantācijas un citu nostiprināšanas paņēmieni izmantošanu, it īpaši, veicot revīzijas operāciju, lai ievietotu un nostiprinātu ierīci.

UZMANĪBU! Tālāk minētie apstākļi atsevišķi vai kopā mēdz radīt smagu slodzi skartajai ekstremitātei, tādējādi radot pacientam lielāku gūžas locītavas endoprotezēšanas neveiksmes risku.

1. Aptaukošanās vai pārmērīgs pacienta svars.
2. Roku darbs.
3. Mērenas vai lielas slodzes sporta aktivitātes.
4. Augsts pacienta aktivitātes līmenis.
5. Kritienu iespējamība.
6. Alkohola vai narkotiku atkarība.
7. Cita attiecīga darbnespēja.

UZMANĪBU! Tālāk minētie apstākļi atsevišķi vai kopā mēdz nelabvēlīgi ietekmēt gūžas locītavas nomaināmas implantu fiksāciju.

1. Izteikta osteoporoze vai nepietiekams kaulvielas daudzums.
2. Metaboliski traucējumi vai sistēmiska farmakoloģiska terapija, kas izraisa progresējošu cietā kaula atbalsta bojājumu implanta vietā (piemēram, cukura diabēts, glikokortikoidu terapija, imūnsupresīva terapija u. c.).

3. Vispārējas vai lokālas infekcijas anamnēzē.
4. Smagas deformācijas, kas rada nepareizu fiksāciju vai neatbilstošu implanta pozicionēšanu.
5. Atbalstošo kaula struktūru audzēji.
6. Alerģiskas reakcijas pret implanta materiāliem (piem., kaulu cementu, metālu).
7. Audu reakcijas pret implanta koroziju vai implanta nodiluma daļiņām.
8. Citu locītavu (t. i., ceļa un potītes) kustību ierobežojums.

PIEZĪME. Diabēts pašlaik nav noteikts kā kontrindikācija. Tomēr ķirurgam ļoti rūpīgi jāapsver ieteikums veikt gūžas locītavas endoprotezēšanu smagi slimiem diabēta pacientiem palielināta komplikāciju riska, piemēram, infekcijas, lēnas brūču dzīšanas u. c. iemeslu dēļ.

Pacienta ķirurģiskā un pēcoperācijas aprūpe ir jāveic, ņemot vērā visus esošos apstākļus. Attieksme vai mentāli traucējumi, kas pacientam liedz ievērot ķirurga norādījumus, var kavēt atveseļošanos pēcoperācijas posmā un/vai palielināt blakusparādību risku, tostarp implanta funkcijas vai implanta fiksācijas traucējumus.

Pārmērīga fiziska aktivitāte vai protezētās locītavas trauma var būt saistīta ar priekšlaicīgu gūžas locītavas endoprotēzes funkcijas traucējumu, radot izmaiņas novietojumā, lūzumu un/vai implantu nodilšanu.

PAREDZAMIE KLĪNISKIE IEGUVUMI

Paredzams, ka pilnīga gūžas artroplastija nodrošinās pacientam lielāku mobilitāti un samazinās sāpes, aizvietojojot bojāto gūžas locītavas artikulējošo virsmu pacientiem ar nobriedušu skeletu, ja ir pierādījumi tam, ka ir pietiekami daudz pamatkaula, lai ievietotu un nostiprinātu komponentus.

DROŠUMA UN KLĪNISKĀS VEIKTSPĒJAS KOPSAVILKUMS (SSCP)

Dažās valstīs vai reģionos ir gūžas locītavu endoprotēžu reģistri, ar kuru palīdzību tiek uzraudzīta gūžas locītavu implantu veiktspēja. Šie reģistru dati tika analizēti un parāda, ka kopumā 95 % gadījumu (95 no 100 gadījumiem) personas pirmās pilnās gūžas locītavas endoprotēzes kalpo ilgāk par 10 gadiem. Tas nozīmē, ka 10 gadu laikā aptuveni 5 % (5 no 100) pacientu, iespējams, tika veiktas papildu operācijas, lai izņemtu vienu vai vairākas daļas. Kopumā 80 % no revīzijas gūžas endoprotēzēm kalpo ilgāk nekā 10 gadus. Šī ierīce atbilst šim vispārējam implanta kalpošanas laikam. Revīzijas risks atsevišķam pacientam būs atkarīgs no konkrētā pacienta faktoriem, piemēram, anatomijas, veselības stāvokļa un dzīvesveida (piem., svara un aktivitātes līmeņa), ķirurģiskās procedūras un procesa.

Ierīcei specifisku drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkumu var atrast šajā saitē: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Piezīme. Eudamed saite būs pieejama tikai pēc tam, kad tiks palaista Eudamed datubāze.

Ziņošana par nopietniem negadījumiem

Par visiem nopietniem negadījumiem, kas notikuši saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.

Nopietns negadījums ir jebkurš negadījums, kas tieši vai netieši izraisīja, varēja izraisīt vai varētu izraisīt:

- a) pacienta, lietotāja vai citas personas nāvi;
- b) īslaicīgu vai pastāvīgu nopietnu pacienta, lietotāja vai citas personas veselības stāvokļa pasliktināšanos;
- c) nopietnus draudus sabiedrības veselībai.

LIETOŠANAS INFORMĀCIJA

Pirms operācijas

PIRMS OPERĀCIJAS ĶIRURGAM JĀAPSPRIEŽ AR PACIENTU VISI PACIENTA FIZISKIE UN GARĪGIE IEROBEŽOJUMI UN VISI OPERĀCIJAS UN ENDOPROTĒZES ASPEKTI. Sarunā jāiekļauj locītavas endoprotezēšanas ierobežojumi un iespējamās sekas, nepieciešamība pēc operācijas ievērot ķirurga norādījumus un pacienta brošūrā sniegtā informācija.

Pirmsoperācijas plānošana un gūžas locītavas endoprotēzes komponentu implantēšanā izmantotās ķirurģiskās metodes ir noteiktas ķirurģiskajā pieredzē, kas iegūta, izstrādājot lielu gūžas locītavas endoprotēžu skaitu. Ķirurgi nedrīkst sākt izmantot klīniskajā praksē nevienu gūžas locītavas endoprotēzi, pirms nav rūpīgi iepazīnušies ar tai paredzēto implantēšanas metodi. Brošūras par ķirurģisko metodi ir pieejamas uzņēmumā DePuy.

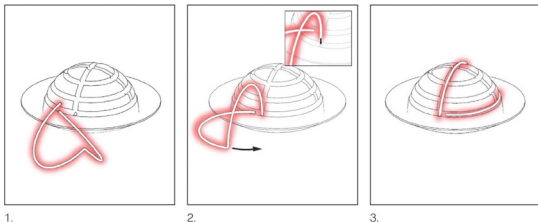
Operācijas laikā

Ieteicams, lai operācijas laikā parocīgā attālumā būtu vismaz vienu izmēru lielāki un vienu izmēru mazāki komponenti, nekā noteikts pirms operācijas, lai operācijas laikā pielāgotu izmēra(-u) izvēli.

Kamēr komponenti tiek sagatavoti protezēšanai, aizsargpārvalkus nedrīkst noņemt. Neizmantojiet komponentus, ja tie ir nomesti vai sadārušies ar cietu virsmu. Komponenta bojājums var nebūt redzams, bet var izraisīt agrīnu endoprotēzes bojājumu. Ķirurģiskajā metodē norādītie ķirurģiskie instrumenti ir paredzēti šai artroplastijas procedūrai, un tie ir jāizmanto, kā norādīts ķirurģiskās metodes brošūrā.

Veicot revīzijas operāciju, obligāti jānoņem visa šķiedrainā membrāna, kas iekapsulē bojāto endoprotēzi. Pārpalikušās šķiedrainās membrānas var ietekmēt implanta fiksāciju. Novērtējiet līdzšinējās ierīces, lai noteiktu,

vai to savienojuma virsmas nav bojātas, jo tādā gadījumā, iespējams, nevarēs pienācīgi ievietot vai fiksēt jauno ierīci. Nepareiza implantu izvēle, novietojums vai izvietošana var radīt neparastu slodzi un līdz ar to implanta funkcionālā kalpošanas laika samazināšanos. Acetabulāra komponenta anteverijas palielināšana pilnīgas gūžas locītavas endoprotezēšanas gadījumā var izraisīt nestabilitāti un/vai dislokāciju. Pirms slēgšanas operācijas lauks ir rūpīgi jāattīra no kaulu šķembām, lieka kaulu cementa, ectopiska kaula daļām u. c. Svešķermeņi uz metāla/plastmasas vai keramikas/plastmasas virsmas var radīt pārmērīgu nodilumu. Rūpīgi jāpārbauda kustību apjoms, lai noteiktu, vai nav savienojuma neatbilstību, nestabilitātes vai aizķeres, un attiecīgi jākorrigē.



Rentgenogrāfijas marķiera stieples montāža

Pēc operācijas

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pacients stingri ievērotu ķirurga norādījumus un brīdinājumus. Pēcoperācijas aprūpē jāievēro pieņemtā prakse.

Pacients jāizraksta no slimnīcas, sniedzot pilnīgas rakstiskos norādījumus un brīdinājumus par vingrinājumiem un jebkuriem aktivitātes ierobežojumiem. Novietojot komponentus nepareizi vai izmantojot fiksētu gūžas endoprotēzi vai pilnu gūžas endoprotēzi ar modulāru, pagarinātu galviņu vai konusa uznavu, var samazināties locītavas kustību diapazons un palielināties komponentu nodiluma, trieciena vai priekšlaicīgas dislokācijas iespējamība vai revīzijas nepieciešamība. Šādos gadījumos ķirurgam jāinformē pacients, ka jāizvairās no darbībām ar plašu kustību diapazonu.

Ieteicams turpināt periodisku pacienta apsekošanu, jo nav zināms implanta funkcionālais kalpošanas laiks konkrētam pacientam, īpaši saistībā ar implanta fiksācijas un gultņa virsmu uzturēšanu. Radioloģiskie izmeklējumi

jāveic katrā apsekošanas reizē, jāsalīdzina ar iepriekšējo radioloģisko pētījumu rezultātiem un jāsaista ar pacienta klīnisko novērtējumu. Ja konstatē rentgenoloģiskas pārmaiņas, piemēram, rentgenoloģisku aizēnojumus, kaula resorbciju vai izmaiņas implanta novietojumā, šīs pārmaiņas uzmanīgi jānovēro, lai noteiktu, vai tās ir nemainīgas vai progresējošas un vai pacients tiek ārstēts atbilstoši.

BLAKUSPARĀDĪBAS UN KOMPLIKĀCIJAS

Tālāk minētas biežākās blakusparādības un komplikācijas pēc gūžas locītavas artroplastijas.

Vispārīgi

Gūžas locītavas endoprotezēšanas komplikāciju biežums un smagums parasti ir lielāks revīzijas operācijās nekā primārajās operācijās. Biežākās revīzijas operāciju problēmas ietver problēmas incīzijas vietas izvēlē, ektopiska kaula un vecā kaulu cementa izņemšanu, komponentu pozicionēšanu un fiksāciju un/vai atbilstošu kaulu masas atbalstu. Parasti revīzijas operācijās jāreķinās ar pagarinātu operācijas laiku, asins zudumu, palielinātu infekcijas, plaušu embolijas un brūces hematomas risku.

Vispārīgi

1. Endoprotēzes komponentu novietojuma izmaiņas bieži saistītas ar faktoriem, kas minēti nodaļā BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI.
2. Agrīna vai vēlīna endoprotēzes komponentu atvienošanās bieži saistīta ar faktoriem, kas minēti nodaļā BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI.
3. Femorālās kājiņas vai kausiņa komponenta noguruma lūzums bieži saistīts ar faktoriem, kas minēti nodaļā BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI.
4. Pārmērīgs nodilums vai balsta komponentu lūzums, ko izraisa: endoprotēzes komponentu intraoperatīvs bojājums, atdalījušās cementa daļiņas, kaula fragmenti, metāla daļiņas, keramiskas daļiņas vai citi faktori, kas minēti nodaļā BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI.
5. Agrīna vai vēlīna infekcija.
6. Perifērās neiropātijas. Iespējams arī subklīnisks nervu bojājums ķirurģiskas traumas rezultātā.
7. Audu reakcijas, osteolīze un/vai implanta vaļīgums metāla korozijas, alerģisku reakciju, nodiluma vai daļiņu atlieku (piemēram, atdalījušos cementa, metāla, polietilēna vai keramikas daļiņu) dēļ.
8. Nenovērstās sāpes gūžā.

Operācijas laikā

1. Femorālās vārpstas vai gūžas kaula locītaviedobuma perforācija, plīsums vai lūzums, kas var būt par iemeslu iekšējās fiksācijas izmantošanai.
2. Trohantera lūzums.
3. Asinsvadu (piem., iegurņa, obturatorā un femorālās artērijas) bojājumi.
4. Īslaicīgs vai paliekošs nervu (piem., femorālā, obturatorā vai izolētā peroneālā nerva) bojājums.
5. Gūžas locītavas subluksācija vai dislokācija implanta izmēra vai konfigurācijas atļases, komponentu pozicionēšanas un/vai muskuļu un saistaudu vājuma dēļ.
6. Skartās ekstremitātes pagarināšana vai saīsināšana.
7. Operācijas aizkavēšanās.

Agrīni pēc operācijas

1. Sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi, tostarp vēnu tromboze, plaušu embolija un miokarda infarkts.
2. Hematoma un/vai kavēta brūces dzišana.
3. Subluksācija vai dislokācija.
4. Modulāro komponentu atdalīšanās.

Vēlīni pēc operācijas

1. Trohantera novirzīšanās pārmērīga muskuļu iestiepuma, noslodzes vai netišas trohantera novājināšanas operācijas laikā dēļ.
2. Problēmu pastiprināšanās ipsilaterālās vai kontralaterālās ceļa un potītes locītavās kāju garuma atšķirības, augšstilba medializācijas un/vai muskuļu nepietiekamības dēļ.
3. Gūžas kaula locītaviedobuma vai augšstilba kaula lūzums traumas vai pārmērīgas noslogošanas dēļ, it īpaši, ja ir nepietiekams kaulvielas daudzums smagas osteoporozes dēļ, iepriekšējās operācijas izraisītu kaulu defektu dēļ, intraoperatīvu pielāgošanas procedūru vai kaula rezorbcijas dēļ.
4. Kaula rezorbcija, kas var veicināt fiksācijas pasliktināšanos un iespējamu implanta atdalīšanos.
5. Periartikulāra pārkalķošanās vai osifikācija, kas var izraisīt locītavas kustīguma un kustību apjoma samazināšanos.
6. Ipsilaterālā ceļa traumatiska artroze sekundāri intraoperatīvai ekstremitātes pozicionēšanai operācijas laikā.
7. Subluksācija vai dislokācija.
8. Modulāro komponentu atdalīšanās.

MAGNĒTISKĀS REZONANSES ATTĒLVEIDOŠANAS (MRI) DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



MRI drošības informācija

Pacientu ar DePuy MARATHON™ XLPE cementētu gūžas locītavas protēzes konstrukciju drīkst skenēt, ievērojot tālāk norādītos nosacījumus. Šo apstākļu neievērošanas rezultātā iespējama trauma pacientam.

Ierīces nosaukums / identifikācija	MARATHON XLPE gūžas endoprotēze ar cementējamu kausiņu
Statiskā magnētiskā lauka nominālvērtība(-as) [T]	1,5 T vai 3,0 T
Maksimālais telpiskā lauka gradients (T/m un gauss/cm)	30 T/m (3000 gauss/cm)*
RF ierosme	Cirkulāri polarizēta (CP)
RF pārraidīšanas spoles tips	Visa ķermeņa pārraidīšanas spole, RF pārraidīšanas-uztveršanas spole galvai
Darbības režīms	Normāls darbības režīms
Maksimālais visa ķermenī	2,0 W/kg (normālā darbības režīmā)
Maksimālais galvas specifiskās absorbcijas ātrums (SAR)	Galvas spoles izmantošana gūžas locītavas skenēšanai nav nepieciešama
Skenēšanas ilguma ierobežojumi	2,0 W/kg visa ķermeņa vidējā SAR Skenēšana līdz 15 minūtēm, kam seko 15 minūšu dzesēšanas periods (to var atkārtot līdz trim reizēm vienā attēlveidošanas sesijā)
MR attēla artefakts	Nav gaidāms, ka šī implanta klātbūtne radīs attēla artefaktu, kas sniegtos tālāk nekā 108 mm*
Papildu norādījumi vai informācija, kas ir būtiska drošai lietošanai MR vidē.	* Pārbaudiet visas gūžas konstrukcijas sastāvdaļas, lai iegūtu papildu informāciju par MR marķēšanu.

IZNĪCINĀŠANA

Rūpīgi iznīciniet visas izmantotās ierīces saskaņā ar vietējām procedūrām un vadlīnijām.

Cementowana proteza panewki stawu biodrowego MARATHON™ XLPE

WAŻNE INFORMACJE — Przeczytać przed użyciem

Niektóre produkty mogą nie być objęte licencją we wszystkich krajach



STERILE

Metodę wskazano na etykiecie produktu

Strona internetowa z instrukcją użytkowania (IFU)

Elektroniczną instrukcję użytkowania oraz wersje w innych językach można znaleźć pod adresem www.e-IFU.com

Karta implantu, ulotka informacyjna dla pacjenta (PIL) i strona internetowa

Karta implantu (i etykieta karty implantu) jest dołączana do opakowania wraz z implantem. Informacje zawarte w ulotce informacyjnej dla pacjenta opierają się na informacjach zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania. Elektroniczną ulotkę informacyjną dla pacjenta można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

Elektroniczną ulotkę dla pacjenta można znaleźć pod adresem www.ic.jnjmedicaldevices.com

OPIS WYROBU

Jest to element panewkowy z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) z metalowymi drutami znacznikowymi RTG. Całkowita proteza stawu biodrowego składa się z metalowego trzpienia do kości udowej do stawu biodrowego, modułów metalowej lub ceramicznej głowy kości udowej i elementów panewkowych: dwuczęściowych z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) na podbudowie metalowej, ceramicznych lub wykonanych w całości z UHMWPE, zaprojektowanych w celu zastąpienia naturalnej powierzchni stawowej stawu biodrowego. Wszystkie elementy protezy są pakowane w indywidualne opakowania.

MATERIAŁY I SUBSTANCJE OBJĘTE OGRANICZENIAMI

Wykaz substancji obecnych w implancie przedstawiono poniżej. Ze względu na proces produkcji wyrób może zawierać dodatkowe substancje śladowe. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem podanym poniżej.

Wyroby te są konstrukcjami wykonanymi z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (97–99% w/w), stopu tytanu (1–2% w/w) oraz stopu stali nierdzewnej (poniżej 1% w/w), w zależności od wielkości.

Przykładowy akronim używany na etykiecie (lub etykietach):	Opis materiału:	Materiał nominalnie zawiera następujące substancje:
PE, UHMWPE, P1	Polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej	Polietylen (100%)
T1, Ti1	Stop tytanu	Tytan (90%) Glin (6%) Wanad (4%)
S2, SS2	Stop stali nierdzewnej (316L)	Żelazo (62%) Chrom (18%) Nikiel (14%) Molibden (3%) Mangan (2%)

SPOSÓB DOSTARCZANIA

Te wyroby są dostarczane w stanie JAŁOWYM, w indywidualnych opakowaniach. Należy je wyjąć z opakowania, stosując zatwierdzoną technikę aseptyczną, dopiero po określeniu prawidłowego rozmiaru. Nie wolno używać tych elementów, jeśli opakowanie jałowe wygląda na uszkodzone lub zostało przypadkowo otwarte.

UŻYTKOWNIK DOCELOWY

Wyroby nie są przeznaczone do użytku przez niewykwalifikowany personel. Bardzo ważne jest, aby chirurg i członkowie personelu sali operacyjnej w pełni znali technikę chirurgiczną odpowiednią do implantu i powiązanych narzędzi.

PRZEZNACZENIE (DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW)

Przeznaczenie

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego ma zastępować uszkodzony mechanizm stawu biodrowego u pacjentów, u których stwierdzono mocną masę kostną wystarczającą do osadzenia i podparcia elementów.

OSTRZEŻENIE: Wraz z modułowymi trzpieniami do kości udowej DePuy należy stosować wyłącznie modułowe głowy kości udowej DePuy i elementy panewkowe DePuy. Zewnętrzna średnica głowy kości udowej MUSI być zgodna z wewnętrzną średnicą elementu panewkowego.

Elementy cementowane

Wyrób panewkowy z oznaczeniem „Tylko do cementowania” jest przeznaczony do stosowania z cementem kostnym.

POPULACJA PACJENTÓW

Docelowa populacja pacjentów obejmuje pacjentów z dojrzałym układem kostnym i stwierdzoną mocną masą kostną wystarczającą do osadzenia i podparcia elementów.

WSKAZANIA

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest wskazana w następujących stanach:

1. duże nasilenie bólesności i/lub stanu zapalnego stawu (zwykle wskutek niezapalnej choroby zwyrodnieniowej stawów);
2. niepowodzenie poprzedniej operacji stawu biodrowego;
3. ostre złamanie głowy lub szyjki kości udowej.

PRZECIWWSKAZANIA

Następujące stany są przeciwwskazaniami do całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego:

1. czynne zakażenie miejscowe lub ogólnoustrojowe;
2. utrata tkanki mięśniowej, upośledzenie nerwowo-mięśniowe lub niewydolność naczyniowa w chorej kończynie, wskutek czego zabieg jest bezzasadny;
3. słaba jakość kości, jak np. przy osteoporozie, w przypadku której w opinii chirurga może dojść do znaczącej migracji protezy lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo złamania trzonu kości udowej, oraz/ lub nie ma wystarczającej masy kostnej do podparcia implantu (lub implantów);
4. staw Charcota lub choroba Pageta.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZESTROGA:

- Nigdy nie wolno używać razem implantów oraz próbných elementów pochodzących od różnych producentów lub z różnych systemów implantów.
- Nigdy nie należy ponownie wszczepiać elementów protezy stawu biodrowego. Nawet jeśli implant wydaje się nieuszkodzony, mogły

w nim powstać mikroskopijne niedoskonałości, które mogą prowadzić do niepowodzenia zabiegu.

- Do celów próbnych zawsze należy używać protezy próbnej. Elementów próbnych nie należy montować w jedną całość z żadnymi elementami przeznaczonymi do wszczepienia na stałe. Elementy próbne muszą mieć taką samą konfigurację, ten sam rozmiar itp. co odpowiadające im elementy przeznaczone do wszczepienia na stałe.
- Wyroby jednorazowego użytku produkowane przez firmę DePuy nie są przeznaczone do jakiegokolwiek modyfikowania, takiego jak demontaż, czyszczenie lub powtórna sterylizacja, po zastosowaniu u jednego pacjenta. Ponowne użycie wyrobu może negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz na bezpieczeństwo pacjenta.
- Nie wolno w żaden sposób zmieniać ani modyfikować implantów, chyba że jest to zgodne z opisem w technice chirurgicznej.
- Wysoka jakość łożyska kostnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zamocowania wyrobu. Należy rozważyć przeszczep kości i inne techniki wzmacniania, zwłaszcza podczas zabiegów rewizyjnych, w celu osadzenia i podparcia wyrobu.

PRZESTROGA: Następujące stany występujące pojedynczo lub równocześnie mogą powodować silne obciążenie chorej kończyny, co zwiększa ryzyko niepowodzenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego u pacjenta:

1. otyłość lub nadmierna masa ciała pacjenta;
2. praca fizyczna;
3. uprawianie sportów wymagających średniej lub dużej sprawności fizycznej;
4. wysoki poziom aktywności pacjenta;
5. prawdopodobieństwo upadków;
6. uzależnienie od alkoholu lub narkotyków;
7. inne formy niepełnosprawności, na ile mają zastosowanie.

PRZESTROGA: Następujące stany występujące pojedynczo lub równocześnie mogą niekorzystnie wpływać na mocowanie implantów w endoprotezoplastyce stawu biodrowego:

1. wyraźna osteoporoza lub słabe łożysko kostne;
2. zaburzenia metaboliczne lub ogólnoustrojowe leczenie farmakologiczne prowadzące do postępującego pogarszania się mocnego kostnego podparcia implantu (np. cukrzyca, leczenie steroidami, leczenie immunosupresyjne itp.);
3. zakażenia ogólnoustrojowe lub miejscowe w wywiadzie;
4. silne zniekształcenia prowadzące do pogorszonego mocowania lub niewłaściwego pozycjonowania implantu;

5. guzy wspierających struktur kostnych;
6. reakcje alergiczne na materiały, z których wykonano implanty (np. cement kostny, metal);
7. reakcje tkankowe na korozję implantu lub pozostałości powstające w wyniku zużycia się implantu;
8. niepełnosprawność w obrębie innych stawów (np. kolanowych i skokowych).

UWAGA: Obecnie cukrzyca nie stanowi stwierdzonego przeciwwskazania. Jednak ze względu na zwiększone ryzyko powikłań, takich jak zakażenie, powolne gojenie się ran itp., lekarz powinien dokładnie rozważyć celowość endoprotezoplastyki stawu biodrowego u chorego na ciężką cukrzycę.

Leczenie chirurgiczne i pozabiegową opiekę nad pacjentem należy prowadzić z należytym uwzględnieniem wszystkich istniejących schorzeń. Postawy psychiczne lub zaburzenia skutkujące niestosowaniem się pacjenta do poleceń chirurga mogą opóźniać powrót do zdrowia po zabiegu i/lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych, w tym niepowodzenia implantu lub jego mocowania.

Nadmierna aktywność fizyczna lub uraz wymienionego stawu mogą przyczyniać się do przedwczesnego niepowodzenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego, powodując zmianę pozycji, złamanie i/lub zużycie implantów.

OCZEKIWANE KORZYŚCI KLINICZNE

Oczekuje się, że całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego zwiększy mobilność pacjenta oraz ograniczy ból poprzez wymianę uszkodzonego mechanizmu stawu biodrowego u pacjentów z dojrzałym układem kostnym i stwierdzoną mocną masą kostną wystarczającą do osadzenia i podparcia elementów.

PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI KLINICZNEJ

W niektórych krajach i regionach istnieją rejestry zabiegów wymiany stawu biodrowego, w ramach których monitorowane jest działanie implantów stawu biodrowego. Na podstawie analizy danych z tych rejestrów wykazano, że pierwszy implant do całkowitej wymiany stawu biodrowego u danej osoby na ogół, tj. u 95% (95 na 100) osób, utrzymuje się dłużej niż 10 lat. Oznacza to, że po 10 latach u około 5% (5 na 100) pacjentów mogły zostać przeprowadzone dodatkowe zabiegi w celu usunięcia części. W przypadku rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego na ogół, tj. u 80% osób, implant spełnia swoją funkcję dłużej niż 10 lat. Opisany wyrób spełnia ten ogólny warunek dotyczący żywotności implantu. U konkretnego pacjenta ryzyko zabiegu rewizyjnego będzie zależało od

specyficznych czynników, takich jak budowa anatomiczna pacjenta, jego stan zdrowia i styl życia (np. masa ciała i poziom aktywności) oraz przebieg zabiegu i całego leczenia chirurgicznego.

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i działania klinicznego dla konkretnego wyrobu można znaleźć pod adresem: <http://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Uwaga: Łącze do bazy danych Eudamed będzie dostępne dopiero po uruchomieniu tej bazy.

Zgłaszanie poważnych zdarzeń

Wszelkie poważne zdarzenia, które wystąpiły w związku z tym wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.

Poważne zdarzenie oznacza każde zdarzenie, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło, mogło doprowadzić lub może prowadzić do któregośkolwiek z poniższych skutków:

- a) zgon pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
- b) czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
- c) poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przed zabiegiem

PRZED ZABIEGIEM CHIRURG POWINIEN OMÓWIĆ Z PACJENTEM WSZYSTKIE OGRANICZENIA FIZYCZNE I PSYCHICZNE DOTYCZĄCE PACJENTA ORAZ WSZYSTKIE ASPEKTY ZABIEGU CHIRURGICZNEGO I PROTEZ. Powinno to obejmować ograniczenia i możliwe konsekwencje endoprotezoplastyki stawu, konieczność przestrzegania zaleceń chirurga po zabiegu oraz informacje zawarte w ulotce dla pacjenta.

Planowanie przedoperacyjne i techniki chirurgiczne wszczepiania tych elementów do endoprotezoplastyki stawu biodrowego stanowią efekt ewolucji doświadczenia chirurgicznego zdobytego podczas opracowywania wielu protez tego stawu. Chirurgzy nie powinni rozpoczynać klinicznego stosowania jakiegokolwiek protezy stawu biodrowego, zanim dokładnie nie zapoznają się z konkretną techniką wszczepiania. Broszury dotyczące technik chirurgicznych są dostępne w firmie DePuy.

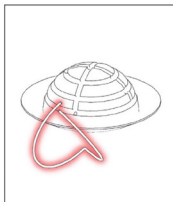
W trakcie zabiegu

Zaleca się, aby podczas zabiegu chirurgicznego dostępne były przynajmniej elementy o jeden rozmiar większe i jeden rozmiar mniejsze, niż określono

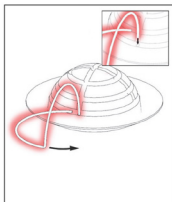
przed zabiegiem, aby umożliwić śródoperacyjny dobór odpowiedniego rozmiaru.

Należy pozostawić osłony ochronne do czasu, gdy elementy będą gotowe do wszczęcia. Nie należy używać elementów, które zostały upuszczone lub uderzyły o twardą powierzchnię. Uszkodzenie elementu może być niewidoczne, ale może spowodować wczesne niepowodzenie zastosowania protezy. Narzędzia chirurgiczne określone w technice chirurgicznej zostały opracowane do tego zabiegu artroplastyki i należy ich używać w sposób pokazany w broszurze dotyczącej techniki chirurgicznej.

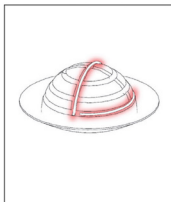
Podczas wykonywania zabiegu rewizyjnego konieczne jest usunięcie wszystkich błon włóknistych otaczających uszkodzoną protezę. Resztki błon włóknistych mogą przeszkadzać w mocowaniu implantu. Należy przejrzeć wszystkie wcześniej zastosowane wyroby pod kątem uszkodzeń powierzchni współpracujących, które mogłyby uniemożliwiać odpowiednie osadzenie lub zablokowanie nowego wyrobu. Niewłaściwy dobór, umieszczenie lub pozycjonowanie implantów może skutkować nietypowymi warunkami naprężeń i w konsekwencji skracać okres funkcjonowania implantu. Zwiększenie przodopochylenia elementu panewkowego w całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego może prowadzić do niestabilności i/lub zwichnięcia. Przed zamknięciem należy dokładnie oczyścić miejsce zabiegu z wiórów kostnych, obcego cementu kostnego, kości ektopowej itp. Ciała obce na powierzchni styku metalu i tworzywa sztucznego lub ceramiki i tworzywa sztucznego mogą powodować nadmierne zużycie. Należy dokładnie sprawdzić zakres ruchu pod kątem nieprawidłowego dopasowania, niestabilności lub uderzania i wprowadzić odpowiednie korekty.



1.



2.



3.

Zestaw drutów znacznikowych RTG

Po zabiegu

Ścisłe przestrzeganie przez pacjenta instrukcji i ostrzeżeń chirurga ma bardzo duże znaczenie. W opiece pozabiegowej należy przestrzegać przyjętych praktyk.

Pacjent powinien zostać wypisany ze szpitala z pełnymi pisemnymi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi ćwiczeń i leczenia oraz wszelkich ograniczeń dotyczących aktywności. Nieprawidłowe ułożenie elementu lub zastosowanie ograniczonej lub całkowitej protezy stawu biodrowego z modułową głową kości z osłoną lub ze zwężającą się tuleją może zmniejszyć zakres ruchu w stawie i zwiększyć ryzyko zużycia elementu, ucisku, przedwczesnego zwknięcia lub rewizji. W takich przypadkach chirurg powinien poinformować pacjenta, że należy unikać czynności o dużym zakresie ruchu.

Ze względu na nieznaną czas funkcjonowania implantu u konkretnego pacjenta, szczególnie w zakresie utrzymania mocowania implantu i powierzchni nośnych, zaleca się stałą kontrolę okresową. Podczas każdej wizyty kontrolnej należy przeprowadzić badania radiologiczne wraz z porównaniem z poprzednimi badaniami radiologicznymi oraz skorelować je z oceną kliniczną pacjenta. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian radiologicznych, takich jak wystąpienie przezierności, resorpcji kości lub jakichkolwiek zmian pozycji implantu, zmiany te należy ściśle monitorować w celu ustalenia, czy są one statyczne czy postępujące, oraz w celu odpowiedniego leczenia pacjenta.

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE I POWIKŁANIA

Poniżej przedstawiono zdarzenia niepożądane i powikłania, które w ogólnym ujęciu najczęściej występują w endoprotezoplastyce stawu biodrowego:

Informacje ogólne

Częstość występowania i nasilenie powikłań w endoprotezoplastyce stawu biodrowego są zwykle większe w przypadku rewizji niż w przypadku zabiegów pierwotnych. Typowe problemy występujące w chirurgii rewizyjnej mogą obejmować trudności w umiejscowieniu nacięcia, usunięciu kości ektopowej i starego cementu kostnego, pozycjonowaniu i mocowaniu elementów oraz/lub uzyskaniu odpowiedniego podparcia kostnego. W ujęciu ogólnym, w przypadku zabiegów rewizyjnych można spodziewać się wydłużenia czasu zabiegu, utraty krwi oraz ryzyka zakażenia, zatoru płucnego i krwiaka rany.

Zdarzenia ogólne

1. Zmiana pozycji elementów protezy, często związana z czynnikami wymienionymi w rozdziale OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
2. Wczesne lub późne obluzowanie elementów protezy, często związane z czynnikami wymienionymi w rozdziale OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
3. Zmęczeniowe złamanie trzpienia do kości udowej lub elementu panewkowego, często związane z czynnikami wymienionymi w rozdziale OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
4. Nadmierne zużycie lub złamanie elementów nośnych z powodu śródogoistnego uszkodzenia elementów protetycznych, luźnego cementu, odłamków kostnych, cząstek metalu, cząstek ceramiki lub innych czynników wymienionych w rozdziale OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
5. Zakażenie wczesne lub późne.
6. Neuropatie obwodowe. W wyniku urazu chirurgicznego może również dojść do subklinicznego uszkodzenia nerwów.
7. Reakcje tkankowe, osteoliza i/lub obluzowanie implantu spowodowane korozją metali, reakcjami alergicznymi, zużyciem lub cząstkami (takimi jak cząstki luźnego cementu, metalu, polietylenu lub ceramiki).
8. Ból resztkowy stawu biodrowego.

Zdarzenia w trakcie zabiegu

1. Perforacja, pęknięcie lub złamanie trzonu kości udowej lub panewki, które może wymagać zastosowania stabilizacji wewnętrznej.
2. Złamanie krętarzowe.
3. Uszkodzenie naczyń krwionośnych (np. tętnicy biodrowej, zastłonowej i udowej).
4. Tymczasowe lub trwałe uszkodzenie nerwu (np. nerwu udowego, zastłonowego lub izolowanego nerwu strzałkowego).
5. Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego wskutek doboru rozmiaru lub konfiguracji implantu, pozycjonowania elementów i/lub rozluźnienia mięśni i tkanki włóknistej.
6. Wydłużenie lub skrócenie leczonej kończyny.
7. Opóźnienie zabiegu chirurgicznego.

Zdarzenia niedługo po zabiegu

1. Zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym zakrzepica żylna, zatorowość płucna i zawał mięśnia sercowego.
2. Krwaki i/lub opóźnione gojenie się ran.
3. Podwichnięcie lub zwichnięcie.
4. Rozdzielenie elementów modułowych.

Zdarzenia późno po zabiegu

1. Awulsja krętarza w wyniku nadmiernego napięcia mięśniowego, obciążenia lub nieumyślnego osłabienia krętarza w trakcie zabiegu.
2. Nasilenie problemów w stawach kolanowych i skokowych po tej samej lub po przeciwnej stronie wskutek rozbieżności w długości nóg, medializacji kości udowej i/lub niedoborów tkanki mięśniowej.
3. Złamanie panewki lub kości udowej wskutek urazu lub nadmiernego obciążenia, szczególnie w przypadku słabego łożyska kostnego spowodowanego ciężką osteoporozą, ubytkami kości po wcześniejszych zabiegach chirurgicznych, śródoperacyjnymi zabiegami rozwierania lub resorpcją kości.
4. Resorpcja kości, która może przyczyniać się do pogorszenia mocowania, a w ostateczności do obluzowania implantu.
5. Ograniczenie ruchomości stawów i zakresu ruchu (np. może być spowodowane zwapnieniem lub kostnieniem okołostawowym).
6. Urazowa choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego po tej samej stronie w następstwie pozycjonowania kończyny w trakcie zabiegu.
7. Podwichnięcie lub zwichnięcie.
8. Rozdzielenie elementów modułowych.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Informacje na temat bezpieczeństwa
w środowisku rezonansu magnetycznego



U pacjenta, któremu wszczepiono cementowaną protezę panewki stawu biodrowego MARATHON™ XLPE firmy DePuy, można wykonywać badanie metodą rezonansu magnetycznego, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki. Niezastosowanie się do tych warunków może spowodować uraz u pacjenta.

Nazwa/identyfikacja wyrobu	Cementowana proteza panewki stawu biodrowego MARATHON XLPE
Znamionowa wartość (lub wartości) statycznego pola magnetycznego [T]	1,5 T lub 3,0 T

Maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego [T/m i gauss/cm]	30 T/m (3000 gauss/cm)*
Wzbudzenie RF	Polaryzacja kołowa (CP)
Typ cewki nadawczej RF	Cewka nadawcza do badania całego ciała, cewka nadawczo-odbiorcza RF do badania głowy
Tryb pracy	Zwykły tryb pracy
Maksymalny współczynnik dla całego ciała	2,0 W/kg (zwykły tryb pracy)
Maksymalny współczynnik SAR dla głowy	W przypadku skanowania biodra użycie cewki do badania głowy nie jest konieczne
Ograniczenia czasu trwania skanowania	Uśredniony współczynnik SAR dla całego ciała: 2,0 W/kg Skanowanie przez maksymalnie 15 minut, po czym następuje 15-minutowy okres chłodzenia (można powtórzyć to do trzech razy w pojedynczej sesji obrazowania)
Artefakt obrazu MR	Nie oczekuje się, że obecność tego implantu spowoduje artefakt obrazu sięgający dalej niż na odległość 108 mm*
Dodatkowe instrukcje lub informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania w środowisku MR.	* Należy sprawdzić wszystkie elementy konstrukcji protezy stawu biodrowego pod kątem dodatkowych informacji o MR zamieszczanych na etykietach wyrobu.

UTYLIZACJA

Należy bezpiecznie zutylizować wszystkie wyroby zgodnie z lokalnie obowiązującymi procedurami i wytycznymi.

Protéza bedrového kĺbu s cementovanou jamkou MARATHON™ XLPE

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – prečítajte si ich pred použitím

Niektoré produkty nemusia mať licenciu vo všetkých jurisdikciách.



STERILE

Metódu nájdete na štítku výrobku

Webová stránka s návodom na použitie

Prístup k elektronickej forme návodu na použitie (e-IFU) a ďalším jazykom nájdete na stránke www.e-IFU.com

Karta implantátu, písomná informácia pre používateľa (PIL) a webová stránka

Karta implantátu (a štítkov karty implantátu) je súčasťou balenia implantátu. Informácie v písomnej informácii pre používateľa (PIL) sú založené na informáciách uvedených v tomto návode na použitie. Informácia pre používateľa v elektronickej forme sa nachádza na webovej stránke uvedenej nižšie.

Prístup k ePIL nájdete na stránke www.ic.jnjmedicaldevices.com

OPIS POMÔCKY

Toto je acetabulárny komponent z polyetylénu s veľmi vysokou molekulovou hmotnosťou (UHMWPE) s kovovými drôťmi ako röntgenokontraštnými značkami. Úplná náhrada bedrového kĺbu sa skladá z jednotlivo baleného kovového drieru bedrovej časti stehennej kosti, modulárnej kovovej alebo keramickej hlavice stehennej kosti a 2-dielnych acetabulárnych komponentov zložených z polyetylénu s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou (UHMWPE) s kovovým podkladom, z keramiky alebo len z UHMWPE určených na náhradu prirodzeného kĺbového povrchu bedrového kĺbu.

MATERIÁLY A OBMEDZENÉ LÁTKY

Nasledujúce informácie obsahujú zoznam látok v implantáte. V dôsledku výrobného procesu môžu byť prítomné ďalšie stopové látky. Ďalšie informácie získate na nižšie uvedenej adrese.

Tieto pomôcky sú konštrukciou vyrobenou z polyetylénu s veľmi vysokou molekulovou hmotnosťou (97 – 99 hmotnostných %), zliatiny

titánu (1 – 2 hmotnostné %) a zliatiny nehrdzavejúcej ocele (menej ako 1 hmotnostné %) v závislosti od veľkosti.

Príklad skratky použitej na štítku (štítkoch):	Opis materiálu:	Materiál obsahuje nominálne množstvo nasledujúcich látok:
PE, UHMWPE, P1	Polyetylén s veľmi vysokou molekulovou hmotnosťou	Polyetylén (100 %)
T1, Ti1	Zliatina titánu	Titán (90 %) Hliník (6 %) Vanád (4 %)
S2, SS2	Zliatina nehrdzavejúcej ocele (316L)	Železo (62 %) Chróom (18 %) Nikel (14 %) Molybdén (3 %) Mangán (2 %)

SPÔSOB DODANIA

Táto pomôcka (pomôcky) sú balené jednotlivo a dodávajú sa STERILNÉ. Vyberte pomôcku z obalu pomocou schválenej aseptickéj techniky po tom, ako bola určená jej správna veľkosť. Nepoužívajte tieto súčasti v prípade, ak sa sterilné balenie javí ako poškodené alebo ak bolo neúmyselne otvorené.

URČENÝ POUŽÍVATEĽ

Tieto pomôcky nesmie používať nekvalifikovaný personál. Je dôležité, aby boli chirurg i personál v operačnej sále plne oboznámení s vhodnou operačnou technikou pre implantát a používané nástroje.

URČENÉ POUŽITIE (CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV)

Určené použitie

Totálna artroplastika bedrového kĺbu je určená na náhradu poškodeného kĺbového spojenia bedrového kĺbu u pacientov, u ktorých je preukázaná dostatočne zdravá kosť na osadenie a oporu komponentov.

UPOZORNENIE: Používajte iba modulárne femorálne hlavice DePuy a acetabulárne komponenty DePuy s modulárnymi femorálnymi driekmi DePuy. Vonkajší priemer femorálnej hlavice MUSÍ zodpovedať vnútornému priemeru acetabulárneho komponentu.

Cementované komponenty

Táto acetabulárna pomôcka s označením „Len na cementované použitie“ je určená na použitie s kostným cementom.

POPULÁCIA PACIENTOV

Určenou populáciou pacientov sú skeletálne zrelí pacienti, u ktorých je preukázaná dostatočne zdravá kosť na osadenie a oporu komponentov.

INDIKÁCIE

Celková náhrada bedrového kĺbu je indikovaná za nasledujúcich podmienok:

1. Veľmi bolestivý a/alebo artritický kĺb (zvyčajne ako následok nezápalového degeneratívneho ochorenia kĺbu).
2. Neúspešná predchádzajúca operácia bedrového kĺbu.
3. Akútna zlomenina hlavy alebo krčka stehennej kosti.

KONTRAINDIKÁCIE

Nasledujúce stavy sú kontraindikácie náhrady bedrového kĺbu:

1. Akútna lokálna alebo celková infekcia.
2. Úbytok svalstva, narušenie neuromuskulárneho stavu alebo cievna nedostatočnosť v postihnutej končatine, čo vedie k neopodstatnenosti procedúry.
3. Zlá kvalita kostného tkaniva, napríklad v dôsledku osteoporózy, pri ktorej môže podľa názoru operátora dôjsť k významnému posunu endoprotézy alebo môže vzniknúť nebezpečenstvo zlomenia diafýzy stehnovnej kosti, a/alebo nedostatok adekvátneho kostného tkaniva na zaistenie primeranej stability implantátu (implantátov).
4. Charcotova alebo Pagetova choroba.

VAROVANIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA

UPOZORNENIE:

- Implantáty a skúšobné komponenty od rôznych výrobcov alebo systémy implantátov sa nikdy nemajú používať spoločne.
- Komponenty náhrady bedrového kĺbu sa nikdy nesmú opätovne implantovať. Aj keď sa implantát javí ako nepoškodený, mohli sa na ňom vytvoriť mikroskopické poškodenia, ktoré by mohli viesť k jeho zlyhaniu.
- Na skúšobné účely vždy používajte skúšobnú protézu. Skúšobné komponenty sa nemajú spájať so žiadnymi komponentmi určenými na trvalú implantáciu. Skúšobné komponenty musia mať rovnakú konfiguráciu, veľkosť atď. ako zodpovedajúce komponenty určené na trvalú implantáciu.
- Pomôcky vyrobené spoločnosťou DePuy určené na jedno použitie neboli navrhnuté na to, aby po použití u jedného pacienta prešli alebo boli podrobené akémukoľvek druhu úprav, akým je rozoberanie, čistenie

alebo opakovaná sterilizácia. Opakované použitie môže potenciálne ohroziť účinnosť pomôcky a bezpečnosť pacienta.

- Implantáty nijakým spôsobom neupravujte ani nemodifikujte, pokiaľ to nie je popísané v chirurgickej technike.
- Kvalitný kostný materiál je rozhodujúci pre zaistenie fixácie pomôcky. Zvážte kostné štepy a ďalšie spevňovacie techniky, najmä pri vykonávaní revízejnej chirurgie, aby ste pomôcku osadili a podopreli.

UPOZORNENIE: Nasledujúce stavy, jednotlivo alebo súbežne, majú sklon k silnému zaťaženiu postihnutej končatiny, čím je pacient vystavený vyššiemu riziku zlyhania náhrady bedrového kĺbu:

1. Obezita alebo nadmerná hmotnosť pacienta.
2. Manuálna práca.
3. Stredne náročné až veľmi náročné športové aktivity.
4. Vysoká úroveň aktivity pacienta.
5. Pravdepodobnosť pádov.
6. Závislosť od nadužívania alkoholu alebo drog.
7. Prípadne iné zdravotné postihnutie.

UPOZORNENIE: Nasledujúce stavy jednotlivo alebo súbežne majú tendenciu nepriaznivo ovplyvňovať fixáciu implantátov náhrady bedrového kĺbu:

1. Pokročilá osteoporóza alebo slabá kostná hmota.
2. Poruchy metabolizmu alebo systémová farmakologická liečba vedúca k progresívnemu zhoršeniu opory kostnej hmoty pre implantát (napr. diabetes mellitus, steroidné terapie, imunosupresívne terapie atď.).
3. História všeobecnej alebo lokálnej infekcie.
4. Ťažké deformácie vedúce k zhoršenej fixácii alebo nesprávnemu umiestneniu implantátu.
5. Tumory podporných kostných štruktúr.
6. Alergické reakcie na materiály implantátu (napr. na kostný cement, kov).
7. Reakcie tkaniva na koróziu implantátu alebo na úlomky vzniknuté z opotrebenia implantátu.
8. Postihnutie iných kĺbov (kolien a členkov).

POZNÁMKA: Diabetes, v súčasnosti, nebol stanovený ako kontraindikácia. Vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií, akým je infekcia, pomalé hojenie rán atď., by mal lekár starostlivo zvážiť vhodnosť náhrady bedrového kĺbu u závažne diabetického pacienta.

Chirurgický a pooperačný manažment pacienta sa musí vykonávať s náležitým ohľadom na všetky existujúce stavy. Duševné postoje alebo poruchy, ktoré majú za následok, že pacient nedodržiava pokyny lekára,

môžu oddialiť pooperačné zotavenie a/alebo zvýšiť riziko nežiaducich účinkov vrátane zlyhania implantátu alebo fixácie implantátu.

Nadmerná fyzická aktivita alebo trauma nahradeného kĺbu môže prispieť k predčasnému zlyhaniu náhrady bedrového kĺbu tak, že spôsobí zmenu polohy, zlomeninu a/alebo opotrebenie implantátov.

OČAKÁVANÉ KLINICKÉ PRÍNOSY

Úplnou artroplastikou bedrového kĺbu sa očakáva dosiahnutie zvýšenej mobility pacienta a zmenšenie bolesti nahradením poškodeného kĺbového spojenia bedrového kĺbu u pacientov s vyvinutými kosťami, u ktorých je preukázaná dostatočne zdravá kosť na osadenie a oporu komponentov.

ZHRNUTIE BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU (SSCP)

Niektoré krajiny alebo regióny majú registre náhrady bedrového kĺbu, ktoré monitorujú výkonnosť implantátov bedrového kĺbu. Tieto údaje v registri boli analyzované a ukazujú, že úplná náhrada bedrového kĺbu vydrží u 95 % (95 zo 100) pacientov po prvej operácii bedrového kĺbu viac než 10 rokov. To znamená, že po 10 rokoch asi 5 % (5 zo 100) pacientov mohlo podstúpiť ďalšie operácie na odstránenie časti (častí). V prípade revíznej náhrady bedrového kĺbu zvyčajne 80 % vydrží viac ako 10 rokov. Táto pomôcka spĺňa túto všeobecnú životnosť implantátu. Riziko revízie u konkrétneho pacienta bude závisieť od špecifických faktorov pacienta, ako sú jeho anatómia, zdravotný stav a životný štýl (napr. hmotnosť a úroveň aktivity), chirurgický zákrok a postup.

SSCP pre konkrétnu pomôcku nájdete na nasledujúcom odkaze:
<http://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Poznámka: Odkaz Eudamed bude k dispozícii až po zverejnení databázy Eudamed.

Hlásenie závažných udalostí

Akúkoľvek závažnú udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ a/alebo pacient sídli.

Pod závažnou udalosťou sa rozumie akákoľvek udalosť, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla viesť alebo môže viesť k niektorému z nasledujúcich stavov:

- a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé závažné poškodenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- c) závažné ohrozenie verejného zdravia.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Pred operáciou

CHIRURG MUSÍ PRED OPERÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S PACIENTOM VŠETKY FYZICKÉ A MENTÁLNE OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PACIENTA A VŠETKY ASPEKTY TÝKAJÚCE SA OPERÁCIE A PROTÉZY. Konzultácia má zahŕňať obmedzenia a možné následky náhrady bedrového kĺbu, požiadavku nutnosti dodržiavať pooperačné pokyny chirurga a informácie uvedené v príbalovom letáku pre pacienta.

Predoperačné plánovanie a chirurgické techniky implantácie týchto komponentov náhrady bedrového kĺbu sú výsledkom vývoja chirurgických skúseností získaných pri vývoji mnohých náhrad bedrového kĺbu. Chirurgovia nesmú začínať s klinickým používaním akejkoľvek náhrady bedrového kĺbu skôr, než sa dôkladne oboznámia s osobitnou technikou jej implantácie. Brožúry týkajúce sa chirurgickej techniky sú k dispozícii v spoločnosti DePuy.

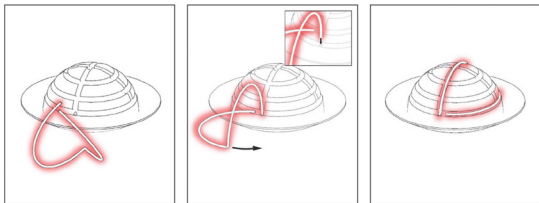
Počas chirurgického zákroku

Odporúča sa, aby pri chirurgickom zákroku boli k dispozícii komponenty najmenej o jednu veľkosť väčšie a jednu veľkosť menšie, ako boli predoperačne stanovené, aby sa počas operácie vyhovelo výberu vhodnej veľkosti.

Ochranné krytie by malo ostať na komponentoch až do momentu ich pripravenosti na implantáciu. Nepoužívajte komponenty po ich páde alebo náraze na tvrdý povrch. Poškodenie komponentu nemusí byť viditeľné, ale môže spôsobiť skoré zlyhanie náhrady. Chirurgické nástroje uvedené v príručke chirurgickej techniky boli navrhnuté pre tento postup artroplastiky a musia byť použité tak, ako je to znázornené v príručke chirurgickej techniky.

Pri vykonávaní revízného chirurgického zákroku je nevyhnutné, aby sa každá fibrózna membrána obaľujúca zlyhanú protézu odstránila ako celok. Reziduálne fibrózne membrány môžu interferovať s fixáciou implantátu. Skontrolujte, či nie sú vzájomne do seba zapadajúce povrchy všetkých už osadených pomôcok poškodené, aby tým nebránili správne osadeniu alebo uchyteniu novej pomôcky. Nesprávny výber, vloženie alebo umiestnenie implantátov môže viesť k nezvyčajným stresovým podmienkam a následnému zníženiu funkčnej životnosti implantátu. Zvýšenie anteverzie acetabulárneho komponentu pri celkovej náhrade bedrového kĺbu môže viesť k nestabilite a/alebo k dislokácii. Pred uzavretím je potrebné chirurgické miesto dôkladne vyčistiť od kostných úlomkov, vonkajšieho kostného cementu, ektopickej kosti atď. Cudzie častice na rozhraní

kov/plast alebo keramika/plast môžu spôsobiť nadmerné opotrebovanie. Rozsah pohybu je potrebné dôkladne skontrolovať z hľadiska nesprávneho spárovania, nestability alebo nárazu a podľa potreby opraviť.



1.

2.

3.

Zostava drôtených röntgenokontrastných značiek

Po chirurgickom zákroku

Je mimoriadne dôležité, aby pacient prísne dodržiaval pokyny a upozornenia lekára. Počas pooperačnej starostlivosti sa majú dodržiavať odsúhlasené postupy.

Pacient má byť prepustený z nemocnice s úplnými písomnými pokynmi a upozoreniami týkajúcimi sa cvičení a terapií a akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa jeho činností. Zlé umiestnenie komponentov alebo použitie obmedzeného bedrového kĺbu alebo úplného bedrového kĺbu s modulárnou hlavou s obrubou alebo kužeľovitou manžetou môže znížiť rozsah pohybu kĺbu a zvýšiť pravdepodobnosť opotrebenia komponentov, impingementu, predčasnej dislokácie alebo revízie. V týchto prípadoch má chirurg informovať pacienta, že sa má vyhnúť aktivitám s veľkým rozsahom pohybu. Odporúča sa pravidelné sledovanie pacienta z dôvodu neznámej funkčnej životnosti implantátu u konkrétneho pacienta, najmä pokiaľ ide o údržbu fixácie implantátu a nosných plôch. Pri každom ďalšom sledovaní sa majú vykonať rádiologické vyšetrenia, ktoré sa majú porovnať s predchádzajúcimi rádiologickými vyšetreniami a korelovať s klinickým hodnotením pacienta. Ak sa pozorujú akékoľvek rádiologické zmeny, akými je výskyt prejasnení, kostná resorpcia alebo akákoľvek zmena v polohe implantátu, tieto zmeny je potrebné starostlivo sledovať, aby sa zistilo, či sú statické alebo či progredujú a či pacient podstúpil vhodnú liečbu.

NEŽIADUCE UDALOSTI A KOMPLIKÁCIE

Vo všeobecnosti sa pri artroplastike bedrového kĺbu najčastejšie vyskytujú nasledujúce nežiaduce udalosti a komplikácie:

Všeobecné

Výskyt a závažnosť komplikácií pri náhrade bedrového kĺbu sú zvyčajne vyššie pri revíziách ako pri primárnych operáciách. Bežné problémy, s ktorými sa stretávame pri revíznej operácii, môžu zahŕňať ťažkosti pri umiestnení rezu, odstránení ektopickej kosti a starého kostného cementu, umiestnení a fixácii komponentov a/alebo dosiahnutí adekvátnej kostnej opory. Vo všeobecnosti sa pri revíziách postupoch dá očakávať predĺžený operačný čas, krvné straty a riziko infekcie, pľúcnej embólie a hematómu rany.

Všeobecné

1. Zmena polohy protetických komponentov, často spojená s faktormi uvedenými v časti VAROVANIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA.
2. Včasný alebo neskorý uvoľnenie protetických komponentov, často spojené s faktormi uvedenými v časti VAROVANIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA.
3. Únavová zlomenina femorálneho drieku alebo komponentu jamky, často spojená s faktormi uvedenými v časti VAROVANIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA.
4. Nadmerné opotrebenie alebo zlomenie nosných komponentov v dôsledku: peroperačného poškodenia protetických komponentov, uvoľnenia cementu, úlomkov kostí, kovových častíc, keramických častíc alebo iných faktorov uvedených v časti VAROVANIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA.
5. Včasná alebo neskorá infekcia.
6. Periférne neuropatie. Taktiež môže dôjsť k subklinickému poškodeniu nervov v dôsledku chirurgického poškodenia.
7. Reakcie tkaniva, osteolýza a/alebo uvoľnenie implantátu spôsobené koróziou kovu, alergickými reakciami, opotrebovaním alebo úlomkami častíc (napr. uvoľnený cement, čiastočky kovu, polyetylénu alebo keramiky).
8. Reziduálna bolesť v bedrovej oblasti.

Počas chirurgického zákroku

1. Perforácia, prasknutie alebo zlomenie diafýzy stehennej kosti alebo jamky, ktoré môžu vyžadovať použitie vnútornej fixácie.
2. Trochanterická zlomenina.

3. Poškodenie krvných ciev (napr. iliakálnej, obturátorovej a femorálnej artérie).
4. Dočasné alebo trvalé poškodenie nervov (napr. femorálneho, obturátorového alebo izolovaného lýtkového nervu).
5. Subluxácia alebo dislokácia bedrového kĺbu v dôsledku veľkosti implantátu alebo výberu konfigurácie, umiestnenia komponentov a/alebo laxnosti svalového a fibrózneho tkaniva.
6. Predĺženie alebo skrátenie postihnutej končatiny.
7. Predĺženie chirurgického zákroku.

Krátko po operácii

1. Kardiovaskulárne ochorenia vrátane venózneho trombozy, pľúcnej embólie a infarktu myokardu.
2. Hematóm a/alebo oneskorené hojenie rán.
3. Subluxácia alebo dislokácia.
4. Oddelenie modulárnych komponentov.

Neskôr po operácii

1. Trochanterická avulzia z nadmerného svalového napätia, záťaže alebo neúmyselného peroperačného oslabenia trochantera.
2. Zhoršenie problémov v ipsilaterálnom alebo kontralaterálnom kĺbe kolena a členka v dôsledku rozdielov v dĺžke nôh, mediácii femuru a/alebo svalových nedostatkov.
3. Acetabulárna alebo femorálna fraktúra v dôsledku traumy alebo nadmerného zaťaženia, najmä pri nedostatku kostnej hmoty spôsobenom ťažkou osteoporózou, kostnými defektmi z predchádzajúceho chirurgického zákroku, postupmi vystružovania počas operácie alebo kostnou resorpciou.
4. Kostná resorpcia, ktorá môže prispieť k zhoršeniu fixácie a prípadnému uvoľneniu implantátu.
5. Zníženie pohyblivosti kĺbov a rozsahu pohybu (môže byť spôsobené napr. periartikulárnou kalcifikáciou alebo osifikáciou).
6. Traumatická artróza ipsilaterálneho kolena sekundárne k peroperačnému umiestneniu končatiny počas operácie.
7. Subluxácia alebo dislokácia.
8. Oddelenie modulárnych komponentov.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MR



Bezpečnostné informácie týkajúce sa MR

Pacienta s konštrukciou bedrovej protézy s cementovou jamkou DePuy MARATHON™ XLPE m je možné skenovať za nasledujúcich podmienok. Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok zranenie pacienta.

Názov/identifikácia pomôcky	Protéza bedrového kĺbu s cementovanou jamkou MARATHON XLPE
Nominálna hodnota (hodnoty) statického magnetického poľa [T]	1,5 T alebo 3,0 T
Maximálny gradient priestorového poľa [T/m a gauss/cm]	30 T/m (3 000 gauss/cm)*
Vysokofrekvenčné budenie	Kruhovo polarizované (CP)
Typ vysokofrekvenčnej vysielačnej cievky	Celotelová vysielačná cievka, vysokofrekvenčná vysielačná a prijímacia hlavová cievka
Prevádzkový režim	Normálny prevádzkový režim
Maximálna celotelová	2,0 W/kg (normálny prevádzkový režim)
Maximálna SAR pre hlavu	Na skenovanie bedrového kĺbu nie je potrebné použitie hlavovej cievky
Obmedzenia doby skenovania	2,0 W/kg priemerná celotelová SAR. Skenovanie do 15 minút, po ktorom nasleduje 15 minút chladenia (môže sa opakovať až trikrát počas jednej relácie zobrazovania)
Artefakt MR obrazu	Neočakáva sa, že prítomnosť tohto implantátu spôsobí obrazový artefakt presahujúci viac než 108 mm*

Ďalšie pokyny alebo informácie nevyhnutné na bezpečné používanie v prostredí MR.	* Skontrolujte všetky komponenty konštrukcie bedrového kĺbu, či neobsahujú ďalšie informácie o označovaní MR.
---	--

LIKVIDÁCIA

Všetky použité pomôcky bezpečne zlikvidujte v súlade s miestnymi postupmi a smernicami.

INTERPRETATION OF SYMBOLS
VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ
SÜMBOLITE TÄHENDUSED
A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
SIMBOLU SKAIDROJUMS
ZNACZENIE SYMBOLI
INTERPRETÁCIA SYMBOLOV

D/DP

DEPUY
 DEPUY
 DEPUY
 DEPUY
 DEPUY
 DEPUY
 DEPUY
 DEPUY



Catalogue Number
 Katalogové číslo
 Katalooginumber
 Katalógusszám
 Katalogo numeris
 Kataloga numurs
 Numer katalogowy
 Katalógové číslo



Batch code
 Kód šarže
 Partii kood
 Gyártási tétel száma
 Partijos kodas
 Partijas kods
 Numer partii
 Kód šarže



Caution
 Upozornění
 Ettevaatust!
 Vigyázat
 Perspėjimas
 Uzmanību!
 Przestroga
 Upozornenie



Consult Instructions for Use
 Přečtěte si návod k použití
 Lugege kasutusjuhendit
 Olvassa el a használati útmutatót
 Žr. naudojimo instrukcijas
 Skatīt lietošanas instrukciju
 Zapoznać się z instrukcją użytkowania
 Pozrite si návod na použití



Manufacturer
 Výrobce
 Tootja
 Gyártó
 Gamintojas
 Ražotājs
 Producent
 Výrobca

STERILE

Sterile
 Sterilní
 Steriilne
 Steril
 Sterilu
 Sterils
 Wyrób jałowy
 Sterilné



www.e-IFU.com
 US / Canada 800-255-2500
 EU: +800 8888 2020
 EU: +32 2 4037222

e-IFU website
 Web e-IFU
 Elektroonilise kasutusjuhendi veebisait
 Elektronikus használati útmutató weboldala
 Elektroninių naudojimo instrukcijų svetainė
 Elektroniskās lietošanas instrukcijas tīmekļa vietne
 Strona internetowa z elektroniczną instrukcją użytkowania (e-IFU)
 Internetová stránka s e-IFU



Use by Date
 Datum použitelnosti
 Säilivusaeg
 Lejárati dátum
 Tinka iki
 Derīguma termiņš
 Data ważności
 Použite do

Sterile GP

Sterilized using gas plasma
 Sterilizováno plyným plazmatem
 Steriliseeritakse gaasiplasma abil
 Gázplazmával sterilizálva
 Sterilizuojama dujų plazma
 Sterilizēts, izmantojot gāzes plazmu
 Wyrób wysterylizowany za pomocą plazmy gazowej
 Sterilizované plynovou plazmou



Do not resterilize
 Neprovádějte opětovnou sterilizaci
 Mitte resteriliseerida
 Ne sterilizálja újra!
 Nesterilizuoti pakartotinai
 Nesterilizēt atkārtoti
 Nie sterylizować ponownie
 Opakovane nesterilizujte



Do not re-use
 Nepoužívejte opakovaně
 Mitte kasutada korduvalt
 Ne használja fel újra!
 Nenaudoti pakartotinai
 Nelietot atkārtoti
 Nie używać ponownie
 Nepoužívajte opakovane



Packaging unit
 Jednotka balení
 Pakendiühik
 Csomagolási egység
 Pakuotė
 Iepakojuma vienība
 Opakowanie jednostkowe
 Jednotka balenia



Do not use if package is damaged
 Nepoužívejte, je-li obal poškozen
 Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
 Ne használja, ha a csomagolás sérült
 Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
 Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
 Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania
 Nepoužívajte, ak je obal poškodený



MR Conditional
 Vyšetření MR možné při splnění daných podmínek
 MR-tingimuslik
 MR-hez kötött
 Sąlyginai saugi MR aplinkoje
 Saderīgs ar MR noteiktos apstākļos
 Wyrób warunkowo bezpieczny w środowisku MR
 Podmieniēne bezpečnė v prostredí MR

MATERIAL

Material(s) of construction
 Výrobní materiál(y)
 Koostematerjal(id)
 Gyártási anyag(ok)
 Konstrukcijas medžiaga (-os)
 Konstruktijas materiāls(-i)
 Materiał(y) konstrukcyjny(-ne)
 Materiāls (materiāli) konstrukcie

MD

Medical Device
 Zdravotnícký prostriedek
 Meditsiiniseade
 Orvostechnikai eszköz
 Medicinos prietaisas
 Medicīniskā ierīce
 Wyrób medyczny
 Zdravotnícka pomôcka



Recyclable
 Recyklovateľný
 Ringlussevõetav
 Újrahasznosítható
 Perdirbama
 Atkārtoti pārstrādājams
 Podlega recyklingowi
 Recyklovateľné

UHMWPE, PE, P1

Ultra-high molecular weight
 polyethylene
 Polyetylén s ultra vysokou molekulovou
 hmotnosťou
 Ülisuure molekulmassiga polüetüleen
 Ultranagy molekulatömegű polietilén
 Ypač didelio molekulinio svorio
 polietilenas
 Īpaši augstas molekulmasas polietilēns
 Polietylen o ultrawysokiej masie
 częścyczkowej
 Polyetylén s veľmi vysokou
 molekulovou hmotnosťou



Double sterile barrier system
 Systém dvojité sterilní bariéry
 Kahekordse steriilse barjääri süsteem
 Dupla, steril zárórendszer
 Dvigubo sterilaus barjero sistema
 Dubulta sterilā barjeras sistēma
 System podwójnej bariery jałowej
 Dvojity sterilný bariérový systém

MADE IN

Made in
 Vyrobeno v
 Valmistamiskoht
 Gyártás helye
 Pagaminimo šalis
 Ražots
 Wyprodukowano w
 Vyrobené v

T1 or Ti1

Titanium
 Titan
 Titaan
 Titán
 Titanas
 Titāns
 Tytan
 Titán

S2, SS2

Stainless steel

Nerezová ocel

Roostevaba teras

Rozsdamentes acél

Nerūdijantysis plienas

Nerūsējošais tērauds

Stal nierdzewna

Nehrdzavejúca ocel'

SIZE/SZ/DIA/IN/ft/ DEG/GRP/lb/OD/ID

Size/ size/ diameter/ inches/ feet/
degrees/ group/ pounds/ outer diameter/
inner diameter

Velikost / velikost / průměr / palce / stopy /
stupně / skupina / libry / vnější průměr /
vnitřní průměr

Suurus/suurus/läbimõõt/tollid/jalad/kraadid/
rühm/naelad/välisläbimõõt/siseläbimõõt

Méret/méret/átmérő/hüvelyk/láb/fok/csoport/
font/külső átmérő/belső átmérő

Dydis / dydis / skersmuo / col. / pėd. /
laipsniai / grupė / sv. / išorinis skersmuo /
vidinis skersmuo

Izmērs/izmērs/diametrs/collas/pēdas/grādi/
grupa/mārciņas/ārējais diametrs/iekšējais
diametrs

Rozmiar / rozmiar / średnica / cale / stopy /
stopnie / grupa / funty / średnica zewnętrzna /
średnica wewnętrzna

Velkost/velkost/priemer/palce/stopy/
stupne/skupina/libry/vonkajši priemer/
vnútorný priemer



DePuy Ireland UC
Loughbeg, Ringaskiddy
Co. Cork
Ireland
Tel: +353 214914000
Fax: +353 214914199



IFU-090260089-EMEA1
Rev. B